



PAUVRETÉ DE L'ENFANT AU SÉNÉGAL

Analyse de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective des
enfants avec une perspective de la COVID-19

2024



PAUVRETÉ DE L'ENFANT AU SÉNÉGAL

Analyse de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective
des enfants avec une perspective de la COVID-19

2024

AUTEURS

Anaïs Dangeot, Chloé Van Damme, Míriam Carrera, Chris de Neubourg

Citation

ANSD & UNICEF 2024. Pauvreté de l'enfant au Sénégal- 62 pages



Préface

L'analyse du chevauchement des privations multiples (MODA) a été réalisée conjointement par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et l'UNICEF. Elle vise à établir le profil de pauvreté des enfants permettant ainsi de mieux orienter le dialogue politique axé sur l'équité et centré sur l'enfant.

La MODA est une approche holistique des aspects multidimensionnels de la pauvreté. Elle englobe un large éventail d'outils allant du dénombrement des privations dans une seule dimension, à l'analyse des chevauchements multiples, aux ratios de privation multidimensionnelle et à leur décomposition (De Neubourg et al., 2013). Cette mesure de la pauvreté contribue à suivre les progrès réalisés par l'Etat du Sénégal sur l'Objectif de Développement Durable (ODD) 1 : « Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde » et plus particulièrement l'ODD 1.2.2 sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Elle complète la pauvreté monétaire qui, elle, ne reflète pas la manière dont la pauvreté touche les enfants aux niveaux physique, émotionnel et social et qui pourrait les empêcher de jouir de tous leurs droits ou encore de participer à la vie de la société en tant que membres à part entière. L'analyse MODA se révèle être ainsi un outil précieux pour évaluer la pauvreté des enfants. Contrairement aux mesures de pauvreté basées uniquement sur les moyens, elle met l'accent sur les résultats, ce qui est essentiel pour des sujets non économiquement actifs tels que les enfants. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2023, les enfants représentent près de la moitié de la population sénégalaise. Les défis et enjeux pour investir sur les enfants demeurent par conséquent une réalité. Ces dernières années, il convient de souligner que le Sénégal a fait des efforts importants pour tendre vers les objectifs fixés dans les traités internationaux. A titre d'exemple, le comité sur les droits de l'enfant note des progrès réalisés dans la mise en conformité par le Sénégal de ses législations, politiques et programmes en phase avec les orientations de la Convention relative aux Droits de l'Enfant. Cependant, le comité souligne en même temps que de tels législations, politiques et programmes ne peuvent être mises en œuvre sans une mobilisation de ressources financières suffisantes, allouées et dépensées de manière efficace, efficiente, équitable, transparente, responsable et durable. Au Sénégal, les investissements dans les secteurs sociaux demeurent encore insuffisants, bien que des résultats prometteurs aient été enregistrés dans des domaines tels que la santé, démontrant ainsi l'impact positif des actions ciblées sur la santé des enfants. Cependant, il faut rester vigilant avec l'apparition de récentes crises multiformes et de nouveaux risques qui peuvent anéantir les années d'efforts consacrées à la pleine réalisation des droits des enfants. Il s'agit notamment des risques liés au changement climatique ou encore les risques liés à la résurgence de pandémie. Sans des actions gouvernementales appropriées, les privations multidimensionnelles risquent de persister, compromettant ainsi la santé, l'éducation et le bien-être des enfants. Mais fort heureusement, des programmes de réponses aux chocs comme la protection sociale adaptative existent pour atténuer l'effet desdits risques sur les enfants.

Sur le plan économique, le Sénégal à l'instar de plusieurs pays de l'Afrique Sub-saharienne a connu ces dernières années une croissance économique soutenue. Avec des taux de croissance affichés autour de 6% depuis 2014, il est attendu une accélération de l'amélioration des conditions de vie des ménages qui devrait se répercuter sur les enfants. Les activités économiques devraient se consolider en tirant profit des effets attendus de la production du pétrole et du gaz ainsi que des différentes mesures de soutien à l'économie nationale dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND). Les politiques sociales au cœur de l'action gouvernementale dans le PND vont permettre au pays de réduire les inégalités.

L'ANSD et UNICEF se réjouissent de la réalisation de cette étude qui vient à son heure. Elle constituera un cadre d'analyse et d'aide à la prise de décision aussi bien pour le Gouvernement que pour tous ses partenaires nationaux et internationaux afin de les inciter à conduire des politiques et programmes appropriés contribuant à la pleine réalisation des droits des enfants.

Table des Matières

Préface	3
Liste des tableaux	6
Liste des figures	7
Acronymes et abréviations	9
Résumé exécutif	10
1. Introduction	16
La pandémie COVID-19 au Sénégal	17
Chocs subis et stratégies de survie	17
Protection sociale des ménages et type de programme	19
2. Méthodologie et données	21
Données	21
Approches à la pauvreté de l'Enfant au Sénégal	21
Pauvreté multidimensionnelle	21
Pauvreté monétaire	23
Pauvreté subjective	23
Comparaison avec les analyses de la pauvreté de l'enfant précédentes	24
3. Résultats : Pauvreté de l'enfants au Sénégal (0-17 ans)	28
Enfants pauvres multidimensionnels et leurs caractéristiques	28
Enfants pauvres monétaires et leurs caractéristiques	30
Enfants pauvres subjectifs et leurs caractéristiques	32
Enfants pauvres monétaires, multidimensionnels et subjectifs et leurs caractéristiques	33
4. Analyse du Chevauchement des Privations multiples par cycle de vie	36
Enfants âgés de 0-4 ans	36
Analyse unidimensionnelle de la privation	36
Analyse multidimensionnelle de la privation	38
Analyse du chevauchement de la privation multidimensionnelle	41
Enfants âgés de 5-14 ans	43
Analyse unidimensionnelle de la privation	43
Analyse multidimensionnelle de la privation	45
Analyse du chevauchement de la privation multidimensionnelle	47
Enfants âgés de 15-17 ans	49
Analyse unidimensionnelle de la privation	49

Analyse multidimensionnelle de la privation	50
Analyse du chevauchement de la privation multidimensionnelle	53
5. Conclusions et recommandations	55
Annexe I : Sélection des paramètres pour l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant en utilisant l'EHCVM 2018/19	57
Annexe II: Formules pour le calcul des taux de privation et des indices de privation multidimensionnelle	59
Annexe III : Module de l'EHCVM sur la pauvreté subjective (section 20)	61
Annexe IV : Caractéristiques du répondant au module de l'EHCVM sur la pauvreté subjective	62

Liste des Tableaux

Tableau 1.	Dimensions et indicateurs retenues par groupe d'âge	22
Tableau 2.	Dimensions, indicateurs et seuils de privation utilisés en 2014 et 2024 rapports sur la pauvreté.	24
Tableau 3.	Taux de privation par indicateur pour les rapports sur la pauvreté 2014 et 2024.	27
Tableau 4.	Prévalence, intensité et indice ajusté pour intensité de la pauvreté multidimensionnelle chez les enfants âgés de 0-17 ans pour un seuil de $k=4$	29
Tableau 5.	Prévalence, intensité et prévalence ajusté pour intensité de la pauvreté multidimensionnelle ($k=4$) chez les enfants âgés de 0-17 ans selon certaines caractéristiques	30
Tableau 6.	Prévalence, intensité et sévérité de la pauvreté monétaire chez les enfants âgés de 0-17 ans pour le seuil absolu de pauvreté monétaire au Sénégal 333 440,5 FCFA	30
Tableau 7.	Prévalence, intensité et sévérité de la pauvreté monétaire (333 440,5 FCFA) chez les enfants âgés de 0-17 ans selon certaines caractéristiques	31
Tableau 8.	Prévalence de la pauvreté subjective (modérée et extrême) chez les enfants âgés de 0-17 ans, %	32
Tableau 9.	Prévalence de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective chez les enfants âgés de 0-17 ans selon le milieu de résidence, %	33
Tableau 10.	Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés par dimension selon certaines caractéristiques	38
Tableau 11.	Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 0-4 ans avec $K=4$	40
Tableau 12.	Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés par dimension selon certaines caractéristiques	44
Tableau 13.	Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 5-14 ans avec $K=4$	45
Tableau 14.	Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés par dimension selon certaines caractéristiques	50
Tableau 15.	Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 15-17 ans avec $K=4$	51
Tableau 16.	Liste des paramètres (dimensions, indicateurs et groupe d'âge) de l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant	57
Tableau 17.	Liste des participants aux ateliers de sélection des paramètres pour l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant	58

Liste des Figures

Figure 1.	Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans privés simultanément pour 0 à 7 dimensions	29
Figure 2.	Prévalence de la pauvreté multidimensionnelle chez les enfants âgés de 0-17 ans selon la région de résidence, %	33
Figure 3.	Prévalence de la pauvreté monétaire (FGT0 ou P0) chez les enfants âgés de 0-17 ans selon la région de résidence, %	34
Figure 4.	Prévalence de la pauvreté subjective chez les enfants âgés de 0-17 ans selon la région de résidence, %	34
Figure 5.	Chevauchement de la prévalence des trois types de pauvreté chez les enfants âgés de 0-17 ans : monétaire, multidimensionnelle et subjective, %	35
Figure 6.	Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés par indicateur et par dimension	36
Figure 7.	Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés par dimension au niveau national et milieu de résidence	37
Figure 8.	Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés simultanément pour 0 à 6 dimensions	39
Figure 9.	Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés simultanément pour 0 à 6 dimensions selon certaines caractéristiques	39
Figure 10.	Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 0-4 ans avec K=4, par région	40
Figure 11.	Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés dans une dimension spécifiée et dans 1, 2, 3, 4, 5 autres	41
Figure 12.	Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés simultanément pour l'assainissement, l'eau et la nutrition	42
Figure 13.	Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés simultanément pour une sélection de 3 dimensions	42
Figure 14.	Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés par indicateur et par dimension	43
Figure 15.	Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés par dimension au niveau national et milieu de résidence	43
Figure 16.	Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés simultanément pour 0 à 7 dimensions au niveau national et selon le milieu de résidence	45
Figure 17.	Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 5-14 ans avec K=4, par région	46
Figure 18.	Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés dans une dimension spécifiée et dans 1, 2, 3, 4, 5 autres	47
Figure 19.	Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés simultanément pour quatre combinaisons de trois dimensions	48
Figure 20.	Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés par indicateur et par dimension	49
Figure 21.	Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés par dimension au niveau national et milieu de résidence	49
Figure 22.	Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés simultanément pour 0 à 7 dimensions au niveau national et selon le milieu de résidence	51
Figure 23.	Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 15-17 ans avec K=4, par région	52

Figure 24. Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés dans une dimension spécifiée et dans 1, 2, 3, 4, 5 autres	53
Figure 25. Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés simultanément pour quatre combinaisons de trois dimensions	54
Figure 26. Part des répondants selon leur lien de parenté avec le chef du ménage, %	62
Figure 27. Part des répondants selon leurs caractéristiques démographiques, %	62
Figure 28. Part des répondants selon leur capacité à lire et à écrire et selon leur achèvement du cycle primaire, %	62

Acronymes et abréviations

ANSD	Agence nationale de statistique et de la démographie
COVID-19	Maladie à coronavirus
EDS	Enquête Démographique et de Santé
EHCVM	Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages
ESPS	Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal
IPM	Indice de pauvreté multidimensionnelle



Crédit Photo: UNICEF Sénégal

Résumé exécutif

Situé en Afrique occidentale, le Sénégal est souvent cité en exemple comme l'un des pays les plus stables au plan politique dans la sous-région. En effet, le Sénégal a été jusqu'ici épargné par les violences qui secouent la sous-région, malgré sa position stratégique (à la pointe de l'Afrique de l'Ouest) et sa vulnérabilité liée aux agissements des groupes terroristes qui sont assez fréquents au niveau de certains pays voisins et le trafic transfrontalier. Selon la Banque Mondiale, l'économie sénégalaise a connu une croissance de plus de 6 % par an entre 2014 et 2018. La croissance du PIB réel s'est toutefois établie à 0,87 % en 2020, contre 4,4 % en 2019 et 6,2 % en 2018¹. En revanche, les résultats de l'enquête EHCVM, en comparaison avec celle de l'ESPS-II, indiquent qu'au niveau national le taux de pauvreté a baissé de 5 points de pourcentage entre 2011 et 2018/2019 pour se situer à 37,8%. Une tendance observée dans les 3 strates (Dakar urbain, Autres urbains et Rural) avec des niveaux différents. En 2011, l'incidence de la pauvreté monétaire chez les enfants² s'élevait à 48,8% chez les 5-14 ans et 47,5% chez les 15-17 ans, comme montré dans le rapport d'étude sur la pauvreté et les disparités chez les enfants. En ce qui concerne la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant, cette étude montre que sur 10 enfants âgés de moins de 5 ans, 8 enfants souffrent d'au moins d'une privation et plus de 6 enfants (62,3%) sont privés dans au moins deux dimensions.

¹ Voir le lien suivant <https://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview>

² Rapport publié en décembre 2014 par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie et de la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale en partenariat avec l'UNICEF Sénégal et l'équipe de recherche de EMAP

La maladie à coronavirus (COVID-19) est apparue au Sénégal le 02 mars 2020 peu avant la déclaration de L'OMS, de l'État d'urgence de Santé publique à portée internationale, à la date du 11 mars 2020. Ainsi, pour interrompre la chaîne de transmission de la maladie, le Gouvernement a pris plusieurs mesures restrictives notamment l'état d'urgence, les couvre-feu, la limitation des déplacements interrégionaux des populations. Bien que les enfants aient largement été épargnés par les effets directs du Covid-19 sur leur santé, du moins jusqu'à présent, la crise a un impact sur leur bien-être. La peur de contracter la maladie dans les structures sanitaires a provoqué une baisse de leur fréquentation ainsi que des services sociaux de base y compris et de façon paradoxale les structures sanitaires. Dans le domaine de la santé, il était question d'anticiper la hausse de la mortalité maternelle et infantile pour limiter les naissances à domicile. Dans le système éducatif, la fermeture des écoles à l'échelle nationale n'est pas sans conséquence sur la qualité de l'éducation dispensée aux jeunes enfants. L'analyse des données collectées par le gouvernement du Sénégal, avec le soutien de l'UNICEF, dans son enquête sur les services sociaux de base a permis d'extraire de nombreux indicateurs sociodémographiques liés à la demande de services sociaux par la population. Cette analyse permet d'appréhender l'impact potentiel de la COVID-19 sur les enfants.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente étude qui a pour objectif principal d'analyser la pauvreté monétaire, non-monétaire ainsi que la pauvreté subjective des enfants au Sénégal en mettant l'accent sur les disparités régionales et sur le genre. Cette analyse vise à mettre à la disposition des décideurs politiques et des gestionnaires de programme, une masse critique d'informations analytiques sur la situation de pauvreté et de vulnérabilité des enfants. Elle permettra de documenter les privations des ménages et des enfants avant la crise sanitaire de COVID-19 pour mieux adresser la question de la réduction de la vulnérabilité et de la pauvreté au Sénégal. Enfin, l'analyse MODA permettra de mettre à jour la situation de référence de l'ODD 1.³

Dans cette étude l'analyse de la pauvreté de l'enfant est réalisée en utilisant trois concepts : la pauvreté multidimensionnelle, la pauvreté monétaire et la pauvreté subjective en utilisant la base de données de l'EHCVM 2018/19, l'enquête harmonisée de l'UEMOA sur les conditions de vie des ménages. L'enquête qui couvre environ 7 100 ménages dans toutes les régions du pays, utilise deux principaux instruments de collecte de données : un questionnaire ménage/individuel et un questionnaire au niveau communautaire. Les enquêtes se sont déroulées en deux phases. La première a été déployée entre septembre 2018 et décembre 2018, tandis que la deuxième s'est déroulée entre avril 2019 et juillet 2019. Pour les besoins de cette étude, la pauvreté monétaire et subjective sont mesurées au niveau du ménage et les résultats imputés à tous les enfants de ce ménage. L'attrait principal de l'utilisation de cette enquête pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle est la possibilité d'analyser le chevauchement des trois types de pauvreté (multidimensionnelle, monétaire et subjective) chez les enfants du même échantillon.

L'Analyse du Chevauchement des Privations Multiples (MODA) a été retenue comme méthode principale d'analyse de la pauvreté et des privations multidimensionnelle de l'Enfant au Sénégal. MODA met l'accent sur le contexte de chaque pays en développant des adaptations nationales de l'approche avec des paramètres d'analyse spécifiques (National-MODA ou N-MODA). En outre, l'approche participative adoptée dans le cadre du développement du N-MODA au Sénégal a permis la définition contextualisée du bien-être des enfants. Cette définition contextualisée a guidé la sélection des paramètres de l'analyse au cours d'un atelier tenu avec toutes les parties prenantes à Dakar, au cours duquel, différentes structures nationales en charge d'assurer les besoins spécifiques des enfants ont participé. De manière générale, cette approche permet l'utilisation de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle pour suivre la cible 1.2 des ODD.

En sus de l'analyse de la privation par indicateur et dimension (analyse sectorielle) les privations pour chaque enfant de l'échantillon sont dénombrées pour estimer la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant au Sénégal. Le seuil de pauvreté multidimensionnelle utilisé pour cette analyse est de $k=4$ privations. En d'autres termes, un enfant est considéré comme multidimensionnellement pauvre, s'il subit des privations dans 4 dimensions ou plus à la fois ; il est à noter que 7 dimensions sont considérées pour cette étude. Il est important de préciser que **les résultats des analyses MODA 2014 et 2024 ne sont pas comparables**. En effet, même si les deux études capturent la pauvreté multidimensionnelle, chacune de ces études utilise différents indicateurs, ce qui empêche d'effectuer une analyse des tendances⁴.

3 La cible 1 des Objectifs de Développement Durable (ODDs), vise à "Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde". En particulier, la cible 1.2 veut "D'ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tout âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu'en soient les formes".

4 Voir les explications détaillées dans la dernière sous-section du chapitre "Méthodologie et données"



PAUVRETÉ DE L'ENFANT AU SÉNÉGAL

Les trois indicateurs de pauvreté monétaire utilisés dans cette étude sont ceux proposés dans la littérature internationale par Foster, Greer et Thorbecke. Ils montrent le ratio de pauvreté, le gap de la pauvreté et la sévérité de la pauvreté pour le seuil national de pauvreté monétaire (absolu) au Sénégal ; 333 440,5 FCFA par personne par an⁵. Le taux de pauvreté monétaire chez les enfants considère le nombre d'enfants des ménages pauvres monétairement en proportion du nombre total d'enfants au Sénégal. Ce taux permet ainsi d'estimer le niveau de représentation des enfants dans les ménages monétairement pauvres. Une composante de la pauvreté subjective a été retenue pour l'étude de la pauvreté de l'enfant au Sénégal. Un ménage, ainsi que les enfants de ce dernier, est considéré comme pauvre subjectivement si le répondant au module sur la pauvreté subjective de l'EHCVM indique que son ménage est "pauvre" ou "très pauvre" en réponse à la question "Quelle est la perception du niveau de vie du ménage sur une échelle de bien-être allant de 1-4 ?".

Les principaux résultats de l'étude de la pauvreté pour la population totale des enfants au Sénégal, c'est-à-dire ceux âgés de 0 à 17 ans, permettent de répondre aux questions suivantes : Quelle est l'incidence et l'intensité de la pauvreté (multidimensionnelle, monétaire et subjective) de l'enfant au Sénégal ? Les trois approches à la pauvreté retenues identifient-elles les mêmes enfants comme étant pauvres ? Quel sont les profils de ces enfants pauvres (multidimensionnel, monétaire et subjectif) ?

Au Sénégal, presque tous les enfants (97,9%) souffrent de privation dans au moins une dimension, et 50,7% d'entre eux sont définis comme pauvres multidimensionnellement pour le seuil (k=4) retenu. En moyenne, ces enfants pauvres multidimensionnels sont simultanément privés dans 4-6 des 7 dimensions retenues pour l'analyse. Les enfants vivant en milieu rural et avec un chef de ménage de sexe masculin ou non diplômés sont les plus pauvres aussi bien en matière d'incidence que d'intensité de la pauvreté multidimensionnelle. Pour ce qui est de la pauvreté monétaire, au Sénégal, 43,3% des enfants âgés de 0 à 17 ans vivent au sein de ménages monétairement pauvres. Pour ce qui est de l'intensité ou du gap de pauvreté, la part de revenu moyen qu'il faut affecter aux enfants pauvres pour les ramener au niveau du seuil de pauvreté est de 12,1%. La sévérité de la pauvreté multipliée par cent est de 4,65. Les caractéristiques du ménage liées à la pauvreté monétaire chez les enfants sont les mêmes que celles associées à la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant. Finalement, ce sont 53,5% des enfants âgés de 0 à 17 ans au Sénégal qui vivent dans des ménages se sentant "pauvres" alors que 7,9% d'entre eux vivent dans des ménages se sentant "très pauvres".

u Sénégal, 34,7 % des enfants sont considérés comme pauvres subjectivement et multidimensionnellement, 30,2 % sont en situation de pauvreté multidimensionnelle et monétaire, 29,4 % sont en situation de pauvreté monétaire et subjective, et 22,3 % des enfants sont pauvres à la fois multidimensionnellement, monétairement et subjectivement. Même si cette dernière catégorie représente une part assez importante de la population des enfants (un peu moins d'un quart), ces résultats montrent que le centrage des politiques sur la pauvreté de l'enfant selon une seule des trois approches porterait à l'exclusion d'un nombre important d'enfants. Par exemple, un programme de cantines scolaires au profit des enfants de ménages monétairement pauvres exclurait 20,8% d'enfants subissant 4 privations ou plus et 23,8% de ménages pensant être pauvres. Ce constat est d'autant plus important en milieu urbain où le chevauchement entre les 3 types de pauvreté est encore plus bas (9%). En milieu rural, le chevauchement entre les 3 types de pauvreté s'élève à 31,5%.

La MODA adopte une approche holistique de la pauvreté et des privations des enfants et permet l'analyse des multiples facettes du bien-être pour différents groupes d'âge. L'approche cycle de vie veut que la définition de la privation évolue avec l'âge de l'enfant. Un enfant jusqu'à l'âge de 6 mois devra être allaité au sein alors qu'un enfant de 17 ans devra être à l'école pour ne pas être privé. Dans le cadre de ces approches, les analyses suivantes ont été réalisées pour chacun des trois groupes d'âge (0-4 ans, 5-14 ans et 15-17 ans): (1) l'analyse unidimensionnelle des privations qui se focalise sur les secteurs les plus pertinents de la privation des enfants; (2) l'analyse multidimensionnelle des privations qui montre et analyse le nombre de privations subies simultanément par chaque enfant; et (3) l'analyse du chevauchement de la privation multidimensionnelle qui permet d'illustrer et d'analyser dans quelles dimensions les enfants sont privés simultanément.

Pour les enfants de 0 à 4 ans, la plus grande privation est observée dans l'utilisation des combustibles solides pour la cuisine et l'accessibilité, à pied, à une structure de santé. En effet, 92,3% des enfants vivent dans un ménage qui utilise des combustibles solides et donc dangereux pour la santé et 79,3% des enfants n'ont pas un accès à pied à une structure de santé. Ensuite, 59,3% des enfants de moins de 5 ans vivent dans des ménages où l'élimination des ordures ménagères pose un problème sans compter que presque la moitié des enfants de 0 à 4 ans n'a pu se nourrir

5 Nous avons retenu le même seuil de pauvreté monétaire que celui utilisé dans le rapport de l'EHCVM publié en 2021.



à sa faim. Enfin, en ce qui concerne l'assainissement, pour 40,3% des enfants de ce groupe d'âge, le type de toilettes n'est pas adéquat. En outre, 20,4% de ces enfants vivent dans des ménages qui partagent les toilettes avec au moins un autre ménage. Les taux de privation les plus importants sont observés pour les dimensions de la Santé (79,8%) et du Logement (65%), après avoir écarté l'indicateur « combustible pour la cuisine ». En revanche, la privation dans la dimension « Eau » concerne moins du quart des enfants de cette tranche d'âge.

Pour les enfants de 5 à 14 ans, la plus grande privation est observée dans les deux indicateurs de la dimension santé, comme pour les enfants de moins de 5 ans. En effet, 92,3% des enfants vivent dans un ménage qui utilise des combustibles nocifs pour la santé et 78,5% des enfants n'ont pas accès à pied à une structure de santé. Pour ce qui est d'une bonne évacuation des ordures ménagères 58,2% des enfants de 5 à 14 ans n'en bénéficient pas. Toutefois, par manque de variance, le premier indicateur a dû être écarté du reste de l'analyse. L'analyse multidimensionnelle des privations montre que 21,4% des enfants de ce groupe d'âge sont privés dans 4 sur les 7 dimensions considérées pour cette analyse. En revanche, seuls 4,2% des enfants de ce groupe d'âge sont simultanément privés dans les 7 dimensions et 1,2% dans aucune des dimensions. En analysant les indices de privation multidimensionnelle, on observe que 58,4% des enfants de ce groupe d'âge subissent une privation simultanée dans au moins 4 des 7 dimensions (4, 5, 6 et 7 inclus) et que ces enfants sont en moyenne simultanément privés dans 5 des 7 dimensions considérées pour cette analyse. L'analyse du chevauchement des privations confirme de nouveau qu'un très faible pourcentage d'enfants (entre 0,03% et 2,93%) est privé dans une seule dimension, quelle que soit la dimension.

Chez les enfants de 15 à 17 ans, la privation la plus importante est observée pour l'indicateur de combustible utilisé pour la cuisine dans la dimension santé (91,5%). Ensuite, 85,7% des enfants de ce groupe d'âge est sans emploi ou ne poursuit pas d'études ni de formation (NEET). Le troisième taux le plus élevé concerne le deuxième indicateur de la dimension santé, l'accessibilité à pied aux structures de santé (75,2%). Toutefois, par manque de variance, les deux premiers indicateurs ont dû être écartés du reste de l'analyse. Les indicateurs pour lesquels les taux de privations sont les plus faibles sont : le traitement de l'eau quand elle provient d'une source inadéquate (8,5%), le surpeuplement (11,4%) et le temps pour aller chercher de l'eau (13,9%). L'analyse multidimensionnelle montre que 24,3% des enfants de ce groupe d'âge est privé dans 3 des 7 dimensions considérées pour cette analyse. Au niveau national, 2,5% des enfants ne sont privés dans aucune des dimensions et 1,4% des enfants subissent des privations dans les 7 dimensions. Le taux de privation multidimensionnelle est de 43,2 % chez les 15-17 ans, et la moyenne des privations est de 4,7 au niveau national. Encore une fois, l'analyse du chevauchement des privations confirme qu'un très faible pourcentage d'enfants est privé dans une seule dimension, quelle que soit la dimension.

Pour ce qui est de la répartition des taux de privation, les tendances suivantes ont été observées:

- o Les différences selon le sexe de l'enfant sont minimes, toutefois les enfants vivant dans un ménage dirigé par un homme sont généralement ceux qui subissent le plus de privations ;
- o Les taux de privation sont plus élevés en milieu rural ;
- o Les régions du sud-est et du sud affichent des taux de privation plus élevés, tandis que celles de l'ouest, et en particulier Dakar, sont moins touchées par les privations ;
- o La couverture du risque maladie est associée à moins de privations ;
- o Le mariage des filles (10-17 ans) est associé à des taux de privation plus importants. L'analyse de cette variable de profil n'a pu être réalisée que pour les filles, faute de données suffisantes pour les garçons du même âge ;
- o La présence d'électricité dans le logement et l'utilisation de matériaux de construction adéquats sont associées à des taux de privation moindres ;
- o On observe peu de différences de privation entre les groupes d'âge, à l'exception de l'analyse unidimensionnelle. Cela peut s'expliquer par la diversité des indicateurs et des dimensions utilisés.

Les résultats des analyses réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de dégager les recommandations suivantes afin d'améliorer les mesures de lutte contre la pauvreté de l'enfant au Sénégal, et de favoriser le bien-être des enfants d'une manière générale.

Recommandations pour améliorer les mesures de pauvreté de l'enfant au Sénégal

1. Réaliser une analyse de la pauvreté subjective des enfants avec comme répondant des enfants d'âges différents et évoluant dans des contextes différents : urbains, ruraux, agro-pastorale, etc. Une telle étude permettrait d'approfondir les résultats quantitatifs de l'analyse décrits dans ce rapport.

2. Plaidoyer pour l'inclusion de plus de variables centrées sur l'enfant dans l'EHCVM, variables du type anthropométrique par exemple. Les variables mesurées au niveau de l'enfant ont l'avantage de mieux faire ressortir les différences entre les profils spécifiques des enfants eux même tels que le sexe par exemple. Il serait également utile de s'inspirer des modules de l'EDS ou du MICS pour l'inclusion de variables propres à l'enfance. Cela permettra notamment de renforcer la mesure des privations pour chaque dimension et contribuera à des recommandations d'actions plus fines et spécifiques aux enfants.

3. Réaliser une analyse des déterminants des pauvretés multidimensionnelle, monétaire et subjective de l'enfant. Nous préconisons une méthode mixte (quantitative et qualitative) pour cet exercice.

4. Analyser la pauvreté dans des contextes de développement différents, par exemple : pauvreté urbaine ou rurale ou dans certaines zones spécifiques. En effet, malgré une prévalence plutôt basse de la pauvreté en zones urbaines par exemple, les enfants qui y sont identifiés comme pauvres ont tendance à quand même subir une forme intense de pauvreté. Il serait intéressant et utile aux décideurs et acteurs de tout bord d'approfondir les connaissances quant à la situation de ces enfants.

Recommandations pour réduire la pauvreté et favoriser le bien-être des enfants du Sénégal

1. Établir un plan d'interventions à plusieurs niveaux pour réduire la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant :
 - o Identifier les dimensions contribuant le plus fortement à la pauvreté multidimensionnelle en utilisant les résultats de l'analyse MODA.
 - o Identifier les liens (de cause à effet) entre ces dimensions et les autres en étudiant de près les résultats des analyses de chevauchement.
 - o Plaidoyer en faveur de la mise en place de programmes multisectoriels (pour les secteurs clés identifiés préalablement).
 - Pour les enfants de 0 à 4 ans : le chevauchement de privations le plus important est observé entre les dimensions assainissement, logement et santé (27 %).
 - Pour les enfants de 5 à 14 ans : le chevauchement de privations le plus important est observé entre les dimensions protection de l'enfant, logement et nutrition (38 %).
 - Pour les enfants de 15 à 17 ans : le chevauchement de privations le plus important est observé entre les dimensions assainissement, logement et nutrition (28 %).
 - o Suivre les résultats de ces programmes en utilisant les indicateurs retenus pour la MODA comme indicateur de performance.
 - o Réaliser des analyses du chevauchement des pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective afin de suivre l'évolution de ce chevauchement à la suite des interventions en faveur des enfants en particulier.

2. Identifier des groupes prioritaires au sein d'un plan de protection sociale national dans à moyen et à long terme. Lorsque les ressources sont limitées, le ciblage est souvent privilégié afin d'affecter les ressources aux populations identifiées comme les plus vulnérables. Si le ciblage peut servir d'outil à court terme, l'adoption d'une approche universelle au niveau national s'avère plus pertinente pour démontrer les résultats positifs d'un programme à long terme. Moins coûteuse dès lors que l'on adopte une vision économique plutôt que comptable, cette approche tient également compte des coûts sociaux liés à la non-intervention auprès de certains groupes. Les profils suivants sont ressortis comme étant le plus souvent associés à la pauvreté, indépendamment du type de pauvreté considéré :

- o Les régions du sud-est en comparaison à celles de l'ouest et en particulier Dakar où la pauvreté est moindre
- o L'accès à l'électricité et l'utilisation de matériaux de construction rudimentaires sont associés à une prévalence plus importante de la pauvreté. Ces données sont facilement observables chez les ménages.
- o En zone rurale, on constate qu'une grande partie des enfants pauvres subjectivement le sont aussi monétairement et multidimensionnellement. Dans ce contexte, l'adoption d'une approche communautaire peut être pertinente pour identifier les enfants en situation de pauvreté.

3. Suivre les tendances en matière de pauvreté de l'enfant à travers des études suivies à intervalle régulier. Le renforcement continu des capacités des différents acteurs à tous les niveaux permettra à terme la réalisation de ces études à l'échelle nationale, régionale et départementale, régional et départemental. Un plan de formation sur le court à moyen terme pourrait prendre la forme suivante :

- o Formation d'acteurs clés aux outils méthodologiques adoptés dans le cadre de cette étude ; en présentiel pour une durée d'une semaine.
- o Réalisation de la prochaine étude par les acteurs précédemment formés avec appui à distance de SPRI ; format coaching tout le long du processus d'analyse jusqu'à la rédaction et la validation du rapport.



Crédit Photo: UNICEF Sénégal



Situé en Afrique occidentale, le Sénégal partage ses frontières avec la Gambie, la Mauritanie, le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau. Doté d'un climat tropical et sec, il compte 17,738 millions d'habitants, dont le quart vit dans la région de Dakar (0,3 % du territoire)⁶.

Le Sénégal est souvent cité en exemple comme l'un des pays les plus stables de la sous-région sur le plan politique. En effet, le Sénégal a été jusqu'ici épargné par les violences qui secouent la sous-région, et ce, malgré sa position stratégique (à la pointe de l'Afrique de l'Ouest), sa vulnérabilité liée aux agissements des groupes terroristes qui sont assez fréquents dans certains pays voisins, et le trafic transfrontalier⁷. Selon la Banque mondiale, l'économie sénégalaise a connu une croissance de plus de 6 % par an entre 2014 et 2018. La croissance du PIB réel s'est toutefois établie à 0,87 % en 2020, contre 4,4 % en 2019 et 6,2 % en 2018. En revanche, les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM), en comparaison avec ceux de l'enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal II (ESPS-II), indiquent que le taux de pauvreté a baissé de 5 points de pourcentage entre 2011 et 2018-2019 au niveau national, pour se situer à 37,8 %. Cette tendance s'observe dans les trois strates (Dakar-urbain, autres villes et milieu rural) à des niveaux différents.

L'incidence de la pauvreté monétaire des enfants a également été calculée en 2014 à partir des données de 2011 de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) du Sénégal. Le taux de pauvreté s'élevait alors à 48,8% chez les 5-14 ans et 47,5% chez les 15-17 ans, comme montré dans le rapport d'étude sur la pauvreté et les disparités chez les enfants⁸. En d'autres termes, environ 1 enfant sur 2 vivait dans un ménage monétairement pauvre⁹. L'ANSD avait aussi estimé l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) au Sénégal en utilisant la méthodologie développée par Alkire & Foster (2007) et les données de l'Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS) 2011. L'indice a été construit en tenant compte des dimensions suivantes : l'Éducation, la Santé, les Conditions de vie, l'Emploi et la Gouvernance et les Institutions. En 2011, le taux de pauvreté multidimensionnelle a alors été estimé à 60.9%. L'intensité des privations, qui correspond au nombre moyen de privations subies par chaque personne pauvre, était de 42.5% du nombre total des privations potentielles (dans 7 dimensions). L'IPM, qui est la multiplication du pourcentage de pauvres et de l'intensité de la pauvreté, est de 0,26. L'indice est principalement utilisé pour comparer différentes zones géographiques et groupes de population, une valeur proche de 1 indiquant des niveaux plus élevés de privation multidimensionnelle. Le taux de pauvreté s'élève à 19,3% à Dakar-urbain, comparé à 45,0% dans les autres villes et 83,9% en milieu rural¹⁰.

En revanche, la dernière étude de pauvreté multidimensionnelle des enfants indique que 8 enfants, âgés de moins de 5 ans, sur 10 souffrent d'au moins une privation. Ils étaient plus de 6 enfants sur 10 (62,3%) à être privés dans au moins deux dimensions. Ces privations constituent des atteintes à leurs droits tels qu'ils sont définis dans la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par le Sénégal, ainsi qu'à leur bon développement et à leur capacité à participer pleinement à la société, dans le présent comme à l'avenir¹¹.

⁶ La Banque Mondiale 2021 selon la projection de la population par l'ANSD.

⁷ Ibid.

⁸ Rapport publié en décembre 2014 par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie et de la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale en partenariat avec l'UNICEF Sénégal et l'équipe de recherche de EMAP

⁹ AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 2018.

¹⁰ Ibid

¹¹ UNICEF Senegal 2021.

La pandémie COVID-19 au Sénégal



Crédit Photo: UNICEF Sénégal

Après les premières infections en Chine en décembre 2019, la maladie à coronavirus (COVID-19) est apparue au Sénégal le 02 mars 2020 juste avant que l'OMS ne déclare la pandémie à la date du 11 mars 2020. La crise sanitaire a poussé les autorités sénégalaises à prendre des mesures restrictives relatives aux déplacements des populations pour interrompre la chaîne de transmission de la maladie. Le Gouvernement a ainsi instauré l'état d'urgence et suspendu les déplacements interrégionaux¹².

En juin 2022, il y a eu un total de 86 175 cas déclarés COVID-19, soit 529 cas pour 100 000 habitants. En termes de décès, il y a eu un total de 1 967 décès, ce qui signifie 12 décès pour 100 000 habitants et un taux de létalité autour de 2%. Concernant la vaccination contre le COVID-19, le Sénégal l'a démarré le 23 février 2021 et a enregistré à la date du 10 octobre 2022 une couverture de 18% de la population âgée de 18 ans et plus soit seulement 1 641 189 ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.¹³

D'un point de vue épidémiologique, il est à noter que les enfants ne sont pas au premier plan de cette pandémie. Toutefois, ils risquent d'en subir les conséquences. Bien qu'ils aient largement été épargnés par les effets directs du COVID-19 sur la santé, du moins jusqu'à présent, la crise a un effet profond sur leur bien-être¹⁴. La peur de la maladie a entraîné au tout début de la pandémie, une baisse de fréquentation des services sociaux de base y compris et de façon paradoxale les structures sanitaires. Ceci avait fait craindre une hausse de la mortalité maternelle et infantile avec l'augmentation des naissances à domicile et la rupture de continuité des services. Dans le système éducatif, la fermeture des écoles à l'échelle nationale n'est pas sans conséquence sur la qualité de l'éducation des jeunes enfants¹⁵.

Chocs subis et stratégies de survie

Dans cette section, sont présentées, les données collectées en 2020 et 2021 par le gouvernement du Sénégal, avec le soutien de l'UNICEF, lors de l'enquête sur les services sociaux de base¹⁶. Le rapport d'enquête a permis d'extraire de nombreux indicateurs sociodémographiques liés à la demande de services sociaux par la population, ce qui a permis d'appréhender l'impact potentiel de la COVID-19 sur les enfants. En effet, dans un contexte où des données microéconomiques post-COVID-19, représentatives au niveau national et pouvant être appariées aux bases de données existantes ne sont pas disponibles, il est difficile d'estimer l'impact réel de la pandémie de la COVID-19 sur les enfants.

Selon l'enquête sur les services sociaux de base du Gouvernement du Sénégal, au niveau national, 67% des ménages

¹² ANSD and UNICEF Senegal 2021.

¹³ Association Mondiale de la Santé (2022).

¹⁴ ANSD and UNICEF Senegal 2021.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ La première vague de cette enquête a été menée durant le mois de novembre 2020 ou 1265 ménages ont été interviewés avec succès, soit un taux de réponse global des ménages de 75%, et la deuxième vague de l'enquête a été menée durant le mois d'avril 2021 ou 1255 ménages ont été interviewés avec succès, soit un taux de réponse global des ménages de 74%.

sont négativement affectés par la pandémie de la COVID-19. En outre, les ménages du milieu urbain sont plus affectés par les différents chocs. La pandémie de la COVID-19 a affecté 78% des ménages en milieu urbain contre 56% en milieu rural. Par exemple, le prix élevé des produits alimentaires a affecté plus de la moitié des ménages (56%) en milieu urbain et le quart (26%) en milieu rural. La région de Kaffrine est la plus affectée par la pandémie de la COVID-19 avec 88% des ménages touchés, suivie de la région de Kolda avec 31%¹⁷.

Quant aux stratégies de survie, l'enquête révèle que pour 33% des ménages ayant subi des chocs liés à la pandémie de COVID-19, aucune stratégie de survie n'a été adoptée et qu'un changement (réduction) dans les habitudes de consommation est adopté par 16% des ménages¹⁸.

Cependant, 14% des ménages ont utilisé leurs épargnes pour surmonter les chocs subis. L'aide reçue des parents et/ou du gouvernement a aussi été une stratégie de survie pour environ 10% des ménages. Dans les régions de Kaffrine et de Tambacounda, le recours au crédit a permis à plus de 10% des ménages de faire face aux chocs liés à la crise sanitaire¹⁹.



Crédit Photo: UNICEF Sénégal

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Protection sociale des ménages et type de programme

Face à l'urgence sanitaire, sociale et économique, le gouvernement du Sénégal a mis en place un programme d'appui à la résilience des ménages pour prendre en charge les conséquences socio-économiques de la pandémie COVID-19.

D'après les résultats de l'enquête, 68% des ménages ont déclaré avoir bénéficié d'une protection sociale durant la crise sanitaire afin d'atténuer les conséquences socio-économiques de la pandémie COVID-19 sur les ménages. Les ménages du milieu rural ont plus bénéficié de protection sociale comparativement à ceux du milieu urbain, soit respectivement 70% et 66%. Le nombre de ménages ayant bénéficié de protection sociale durant la crise varie selon les régions. Ainsi, les ménages de la région de Kaffrine sont ceux qui ont le plus bénéficié de la protection sociale (85%), suivis de ceux de Kolda (79%), de Sédhiou (76%), de Kédougou (75%) et de Tambacounda (67%).²⁰

Concernant le type de programme ou aide reçu par les ménages, au niveau national, 82% ont bénéficié de l'aide alimentaire de l'Etat, 8% de l'aide alimentaire de proche, 7% d'une aide financière autre que le programme cash et 13% d'une réduction de facture d'eau ou d'électricité²¹. Comparativement aux ménages urbains, ceux ruraux ont plus bénéficié du programme cash transfert durant la crise sanitaire avec respectivement 3% et 7%. Cependant, l'aide alimentaire de l'Etat a concerné 84% des ménages en milieu rural et 81% en milieu urbain. Cependant, les aides financières autres que le programme cash de l'Etat sont plus perçues par les ménages du milieu urbain avec 10% contre 5% en milieu rural. Quant à la réduction de facture d'eau et d'électricité, elle a été accordée au niveau national, urbain et rural à 13% des ménages. Cependant, au niveau régional, des disparités sont notées, elles vont de 0,4% pour Kaffrine à 9% pour Sédhiou²².



Crédit Photo: UNICEF Sénégal

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Objectifs de l'étude

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente étude qui a pour objectif principal d'analyser la pauvreté monétaire, non-monétaire ainsi que la pauvreté subjective des enfants au Sénégal en mettant l'accent sur les disparités régionales et sur le genre. Cette analyse vise à mettre à la disposition des décideurs politiques et des gestionnaires de programmes, une masse critique d'information analytique sur la situation de pauvreté et de vulnérabilité des enfants avant la crise sanitaire de la COVID-19. En d'autres termes, cela permettra d'informer les processus de planification et les politiques sectorielles afin qu'ils soient plus axés sur l'équité et centrés sur l'enfant. Elle permettra également de soutenir le processus du nouveau cycle de programmation de coopération entre l'UNICEF et le Gouvernement du Sénégal 2024-2028, surtout en ce qui concerne les régions à forte incidence de pauvreté monétaire et de privation des enfants.

De manière spécifique, l'analyse de la pauvreté des enfants (multidimensionnelle, monétaire et subjective) permet de :

- 4) Mesurer et analyser le niveau de pauvreté monétaire, de privations multiples et de pauvreté subjective des enfants au Sénégal ;
- 5) Etablir le profil de pauvreté des enfants selon différentes tranches d'âges, par sexe et par région pour mieux orienter le dialogue politique et la prise de décision axés sur l'équité et centrés sur l'enfant ;
- 6) Fournir une analyse basée sur l'approche droits des différentes formes de privations multiples chez les enfants ;
- 7) Suivre les progrès réalisés pour l'atteinte de l'ODD 1 en termes de réduction de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle des enfants avant la crise sanitaire de COVID-19 et depuis avril 2020 ;

Les sections suivantes du rapport présenteront la méthodologie utilisée pour estimer la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective, puis les indicateurs, les dimensions et les seuils de privation utilisés pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle par groupe d'âge. Viendra ensuite une présentation des principaux résultats. Le rapport se conclura par la formulation de messages clés et de recommandations stratégiques pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants au Sénégal

2. Méthodologie et données

Dans cette étude, l'analyse de la pauvreté de l'enfant est réalisée en s'appuyant sur trois concepts : la pauvreté multidimensionnelle, la pauvreté monétaire et la pauvreté subjective.

Données

L'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) 2018/2019, a été retenue pour mesurer la pauvreté monétaire, multidimensionnelle et subjective des enfants dans le cadre de cette étude. L'EHCVM Sénégal 2018/19 est la première édition d'une enquête auprès des ménages représentative au niveau national menée dans le cadre du projet d'harmonisation des enquêtes auprès des ménages de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ce programme conjoint de la Banque mondiale et de la Commission de l'UEMOA vise à produire des données d'enquêtes dans les pays membres (Bénin, Burkina Faso, Tchad, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). L'enquête couvre toutes les régions et environ 7 100 ménages. L'enquête utilise deux principaux instruments de collecte des données : un questionnaire ménage/individuel et un questionnaire au niveau communautaire. Les enquêtes se sont déroulées en deux vagues, chaque vague couvrant la moitié de l'échantillon. La première vague a été déployée entre septembre 2018 et décembre 2018, tandis que la deuxième vague s'est produite entre avril 2019 et juillet 2019. L'approche en deux vagues a été choisie pour tenir compte de la saisonnalité de la consommation. Pour les besoins de cette étude, la pauvreté monétaire et subjective sont mesurées au niveau du ménage et les résultats imputés à tous les enfants de ce ménage. L'attrait principal de l'utilisation de cette enquête pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle est la possibilité d'analyser le chevauchement des trois types de pauvreté (multidimensionnelle, monétaire et subjective) chez les enfants du même échantillon.

Approches à la pauvreté de l'Enfant au Sénégal

Pauvreté multidimensionnelle

L'Analyse du Chevauchement des Privations Multiples (MODA) a été retenue comme méthode principale d'analyse de la pauvreté et des privations multidimensionnelle de l'Enfant au Sénégal. MODA adopte une approche holistique de la pauvreté et des privations des enfants, en analysant les multiples facettes du bien-être de ces derniers. La méthodologie a été développée par Innocenti, le bureau de recherche de l'UNICEF, avec le soutien de la division des politiques et de la stratégie de New York, afin de faciliter l'analyse des inégalités et de fournir des instruments pour identifier les enfants victimes de privations.

MODA se concentre sur la pauvreté et les privations de l'enfant, l'enfant est donc l'unité de l'analyse. MODA apporte un certain nombre de contributions originales au débat de la pauvreté multidimensionnelle :

- o **Une approche holistique centrée sur l'enfant.** Le choix des dimensions et des indicateurs est orienté par leur pertinence au regard du bien-être des enfants (besoins essentiels ; droits fondamentaux des enfants). Les multiples aspects de la vie des enfants sont placés simultanément au centre de toute l'analyse et l'enfant est pris en compte dans son intégralité.
- o **Une approche « cycle de vie ».** Les besoins des enfants ne sont pas homogènes au cours de leur enfance. L'approche MODA permet de refléter les différences de ces besoins pour chaque phase de l'enfance (telle que la petite enfance, l'enfance et l'adolescence).
- o **La création de profils d'enfants subissant des privations.** L'analyse MODA aide à l'identification des groupes particulièrement défavorisés ou vulnérables, et permet de déterminer leurs caractéristiques sociales et géographiques.

L'analyse MODA est une méthodologie qui permet de mesurer et de mieux comprendre l'incidence, l'intensité et la sévérité de la pauvreté multidimensionnelle selon la situation géographique et selon certaines caractéristiques des enfants, des ménages auxquels ils appartiennent et de leurs mères. L'approche est composée d'une analyse sectorielle (par indicateur et par dimension) d'une part et d'une analyse multidimensionnelle de l'autre. MODA met l'accent sur le contexte de chaque pays en développant des adaptations nationales de l'approche avec des paramètres d'analyse spécifiques (National-MODA ou N-MODA).

L'approche participative adoptée permet la définition contextualisée du bien-être des enfants au Sénégal. Cette définition contextualisée a guidé la sélection des paramètres de l'analyse au cours d'un atelier tenu à Dakar, où différentes structures nationales en charge du bien-être des enfants ont participé. Il s'agit notamment de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), de l'UNICEF Sénégal en plus des experts des ministères sectoriels (voir la liste des participants dans les annexe de ce rapport). Pour cette raison, le taux de pauvreté multidimensionnelle estimé pourra être utilisé pour le suivi de la cible 1.2 des ODDs pour la population des enfants.

Le Tableau 1 présente la liste des dimensions et indicateurs retenue par groupe d'âge. On peut trouver la liste avec la description détaillée de chaque indicateur dans le Tableau 2²³.

Tableau 1. Dimensions et indicateurs retenues par groupe d'âge

Dimensions	Indicateurs	Group d'âges		
		0-4 ans	5-14 ans	15-17 ans
Assainissement	Type de sanitaire	x	x	x
	Partage des toilettes	x	x	x
Eau	Source d'eau pour boire	x	x	x
	Temps pour aller chercher l'eau	x	x	x
Logement	Débarras des ordures ménagères	x	x	x
	Surpeuplement	x	x	x
Nutrition	Diversité des repas		x	x
	Sécurité alimentaire/ Nonaccès à la nourriture pour se nourrir à sa faim	x	x	x
Santé	Accès à une structure de santé : l'hôpital ou autre centre de santé	x	x	x
Protection de l'enfant	Disponibilité de l'acte de naissance	x	x	
	Travail des enfants (économique et domestique)		x	
	Enfant vivant avec ses parents	x	x	x
Éducation	Capacité de lecture et d'écriture			x
	Fréquentation scolaire		x	

La privation par dimension²⁴ est estimée en mesurant la privation pour chacun de ces indicateurs²⁵. Les indicateurs mesurent différents aspects de la privation dans une dimension donnée et sont agrégés sous cette dimension en utilisant l'approche de l'union. En sus de l'analyse de la privation par indicateur et dimension (analyse sectorielle) le compte des privations pour chaque enfant de l'échantillon est réalisé permettant une analyse multidimensionnelle de la privation (voir annexes). La pauvreté multidimensionnelle de l'enfant est estimée en résumant trois aspects clés de cette analyse pour un seuil (k) de privation multidimensionnelle préalablement établi :

- H, le taux d'incidence de la privation multidimensionnelle : le pourcentage d'enfants d'un groupe d'âge donné privés multidimensionnellement pour un seuil k
- A, l'intensité moyenne de la privation multidimensionnelle : le nombre moyen de privations subis par les enfants privés multidimensionnellement (seuil k) en valeur absolue ou en pourcentage du nombre total des dimensions considérées pour l'analyse.
- M_o , l'indice de l'incidence ajusté (pour intensité) de la privation multidimensionnelle : le produit de H et A (pour un seuil k), en %, résultant en un indice sensible aussi bien à l'incidence qu'à l'intensité de la privation multidimensionnelle.

23 Cible 1.2 de l'ODD 1: D'ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tout âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu'en soient les formes

24 Les mêmes dimensions sont retenues (assainissement, eau, logement, nutrition, santé, protection de l'enfant, éducation) par groupe d'âge. Cependant, pour certaines de ces dimensions, les indicateurs utilisés diffèrent en fonction des besoins spécifiques d'un groupe d'âge. En effet, les indicateurs varient en fonction de la situation spécifique de la tranche d'âge. Par exemple, il ne serait pas pertinent de mesurer la diversité des repas pour les enfants de 0 à 6 mois car les enfants de cet âge devraient encore être allaités ou nourris au lait maternisé exclusivement.

25 Chaque indicateur fournit des informations sur un aspect bien distinct de la privation dans une dimension donnée. Pour cette raison, un enfant qui subit des privations dans au moins un des indicateurs d'une dimension, sera considéré comme subissant des privations. Cette approche est définie comme « l'approche de l'union » selon de Neubourg et al. (2012).

Il est essentiel de définir un seuil de pauvreté afin de distinguer les enfants pauvres de ceux non pauvres. **Le seuil de pauvreté multidimensionnelle utilisé pour cette analyse est de k=4 privations.** En d'autres termes, un enfant est considéré comme pauvre multidimensionnellement, s'il subit des privations dans 4 dimensions ou plus à la fois.

Pauvreté monétaire

Les indicateurs de pauvreté monétaire les plus utilisés dans la littérature sont ceux de la famille proposés par Foster, Greer et Thorbecke. On les appelle aussi les indicateurs FGT. Ces mesures peuvent être désagrégées selon le lieu de résidence de l'enfant ainsi que ses caractéristiques ou ceux de son ménage afin de créer un profil des enfants pauvres monétairement.

Les trois principaux indicateurs utilisés dans cette étude sont le ratio de pauvreté, le gap de la pauvreté et la sévérité de la pauvreté et sont décrites comme suit²⁶.

- Le ratio de pauvreté (FGT0 ou P0) permet d'appréhender l'étendue et la prévalence de la pauvreté monétaire. Il donne le pourcentage de pauvres dans la population totale.
- Le gap de pauvreté (FGT1 ou P1) mesure la profondeur ou l'intensité de la pauvreté monétaire, c'est-à-dire la part de revenu moyen qu'il faut affecter aux pauvres pour les ramener au niveau du seuil de pauvreté.
- La sévérité de la pauvreté (FGT2 ou P2), aussi appelé Écart de pauvreté au carré, prend en compte la distance qui sépare les pauvres de la ligne de pauvreté au carré. Cela revient à pondérer l'écart de pauvreté en fonction de lui-même, de manière à privilégier les personnes en situation d'extrême pauvreté. En d'autres termes, la sévérité de la pauvreté considère l'inégalité parmi les pauvres.

Le seuil national de pauvreté monétaire (absolu) est utilisé pour calculer la pauvreté monétaire ; 333 440.5 FCFA par personne par an²⁷. Le taux de pauvreté monétaire chez les enfants considère le nombre d'enfants total des ménages pauvres monétairement en proportion du nombre total d'enfants au Sénégal. Ce taux permet ainsi d'estimer le niveau de représentation des enfants dans les ménages pauvres monétairement.

Pauvreté subjective

Une composante « pauvreté subjective » a été retenue pour l'étude de la pauvreté de l'enfant au Sénégal. Cette composante permet de percevoir le point de vue sur la notion de la pauvreté et des privations. Cela permet une meilleure prise en compte de la voix des enfants dans les politiques et programmes publics. L'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages 2018-19 (EHCVM), dispose d'un module sur la perception de pauvreté des ménages (voir à la page 27). Ce module permet d'analyser et de comprendre le point de vue des ménages concernant leur (non-) pauvreté. **Un ménage, ainsi que les enfants de ce dernier, est considéré comme pauvre subjectivement si le répondant indique en réponse à la question "Quelle est la perception du niveau de vie du ménage sur une échelle de bien-être allant de 1-4²⁸?" que son ménage est "pauvre" ou "très pauvre".**

Cependant, un seul membre du ménage répond au questionnaire EHCVM sur la perception de la pauvreté. En général, la majorité des répondants sont des chefs de ménage (71,7%), des adultes (99,8%) et des hommes (57,1%) n'ayant pas achevé le cycle primaire (65,2%) mais pouvant lire et écrire (50,3%)²⁹. Pour les besoins de cette analyse, on suppose donc que les enfants de ces ménages pauvres subjectifs le sont également.

²⁶ Voir la Note pour l'analyse de la pauvreté pour des perspectives de comparaison régionale : proposition méthodologique, Document de travail de Siriki Zanga COULIBALY T. AFRISTAT/CERA.
https://www.afristat.org/contenu/doc_travail_experts/Note%20analyse%20regionale%20pauvrete.pdf

²⁷ ANSD 2021.

²⁸ L'échelle de 1-4 avec 1 étant « Riche » et 4 étant « Très pauvre ».

²⁹ Voir l'Annexe IV : Caractéristiques du répondant au module de l'EHCVM sur la pauvreté subjective

Comparaison avec les analyses de la pauvreté de l'enfant précédentes

La dernière analyse MODA réalisée au Sénégal date de 2014. Cette analyse a été réalisée par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ; l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie ; la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale, en partenariat avec l'UNICEF Sénégal et l'équipe de recherche de EMAP. L'étude s'intitulait « Actualisation de l'étude sur la pauvreté et les disparités chez les enfants au Sénégal³⁰ ». Cette étude a été élaborée à partir des données de l'Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples au Sénégal (EDS-MICS) et l'Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS). Les données utilisaient datent de 2010-2011. Le rapport sur la pauvreté du 2014 comprenait des dimensions, des indicateurs et des paramètres différents de l'analyse actuelle. Le tableau 2 ci-dessous présente ces différences.

Tableau 2. Dimensions, indicateurs et seuils de privation utilisés en 2014 et 2024 rapports sur la pauvreté.

Dimensions	Indicateurs	Seuil de privation 2014	Seuil de privation 2024
Logement	Structure du logement	Enfant vivant dans un logement où le matériau du sol, du toit ou des murs est naturel	NON UTILISÉ (Utilisé comme variable de profilage)
	Surpeuplement du logement	Enfant vivant dans un logement sur peuplé (5 personnes ou plus en moyenne par chambre utilisée pour dormir)	Enfant vivant dans un ménage ou dorment plus de 3 personnes par pièces
	Débarras des ordures ménagères	NON UTILISÉ	Enfant vivant dans un ménage utilisant un mode inadéquat de débarras des ordures ménagères.
Eau	Sources d'approvisionnement en eau de boisson	Enfant vivant dans un ménage qui boit une eau provenant d'une source non améliorée (Puits non protégés, Eau de source non protégée, Camion-citerne, Charrette avec petite citerne/tonneau ; eau de surface.	Enfant vivant dans un ménage qui boit une eau provenant d'une source non améliorée (Puits ouvert dans la cour/concession ; Puits ouvert ailleurs ; Source non aménagée ; Fleuve/Rivière/Lac/Barrage ; Vendeur ambulant, Autre.
	Temps pour aller chercher l'eau	NON UTILISÉ	Enfant vivant dans un ménage ou le temps pour aller chercher l'eau excède 30mins indépendamment de la saison (sèche ou des pluies)
Assainissement	Type de sanitaire	Enfant vivant dans un ménage dont les toilettes sont des installations d'assainissement non adéquates (toilettes avec fosse sans chasse ; latrines traditionnelles ; pas the toilettes)	Enfant vivant dans un ménage utilisant des toilettes non améliorées : Latrines sanplat; Latrines dallées simples; Fosse rudimentaire; Toilettes publiques; Aucune toilette; Autre.
	Partage des toilettes	NON UTILISÉ	Enfant vivant dans un ménage partageant les toilettes avec d'autres ménages

30 UNICEF Senegal 2014.

Dimensions	Indicateurs	Seuil de privation 2014	Seuil de privation 2024
Nutrition	Poids/Taille	Enfant en état global de mal-nutrition	NON UTILISÉ (pas disponible)
	Poids/Âge	Enfant en retard de croissance	NON UTILISÉ (pas disponible)
	Taille/Âge	Enfant souffrant d'émaciation	NON UTILISÉ (pas disponible)
	Nombre de repas par jour	Enfant vivant dans un ménage où, au plus deux repas sont servis par jour	NON UTILISÉ (pas disponible)
	Insécurité alimentaire	Enfant vivant dans un ménage régulièrement confronté à des besoins de nourriture non satisfaits	Enfant vivant dans un ménage - qui n'avait plus de nourriture, OU avec un des membres ayant - dû sauter un repas, - mangé moins que ce qu'il pensait nécessaire, - eu faim mais sans avoir mangé-passé toute une journée sans manger au moins une fois durant les 12 derniers mois par manque d'argent ou d'autres ressources
	Diversité des repas	NON UTILISÉ	
Santé	Enfant vivant dans un ménage n'ayant pas consommé d'aliments des 4 groupes alimentaires (carbohydrates, protéines, fruits/légumes, graisses) une fois par jour sur la dernière semaine		
	Assistance en structure	Enfant dont la naissance n'a pas eu lieu dans une structure de santé (maison)	NON UTILISÉ (pas disponible)
	Assistance en personnel qualifié	Enfant dont la naissance n'est pas assistée par un personnel médical qualifié	NON UTILISÉ (pas disponible)
	Vaccination	Enfant Âgé de 12 à 59 moins n'étant pas complètement vacciné	NON UTILISÉ (pas disponible)
	Accès à une structure de santé publique	Temps nécessaire pour se rendre à la structure de santé la plus proche avec le moyen de transport le plus habituel est supérieur à 30 minutes	Enfant vivant dans une localité où il/elle ne peut accéder à pied à une structure de santé
	Utilisation de combustibles solides pour cuisiner	NON UTILISÉ	
	Enfant vivant dans un ménage ou utilisant du combustible solide pour cuisiner: bois ramassé, bois acheté, charbon de bois, déchets animaux, autres		

Dimensions	Indicateurs	Seuil de privation 2014	Seuil de privation 2024
Environnement sécuritaire / Protection de l'enfant	Environnement sécuritaire	Enfant vivant dans un ménage dont un membre au moins a été victime d'une agression ou d'un vol	NON UTILISÉ (pas disponible)
	Travail des enfants (économique et domestique)	Enfant ayant travaillé au moins une heure à son propre compte comme employé rémunéré ou non, apprenti ou aide-familiale, ou s'étant déclaré au chômage (5-14 ans)	Enfant effectuant travail économique ou domestique pendant au moins 1h (5-14 ans)
	Disponibilité de l'acte de naissance	Enfant n'ayant pas d'acte de naissance (0-14 ans)	Enfant n'ayant pas d'acte de naissance (0-14 ans)
	Enfant vivant avec ses deux parents	NON UTILISÉ	Enfant ne vivant pas avec ses deux parents biologiques
Éducation	Fréquentation scolaire	Enfant ne fréquentant pas l'école (5-14 ans)	Enfant ne fréquentant pas l'école (5-14 ans)
	Achèvement du primaire	Enfant ne fréquentant pas l'école ou n'ayant pas terminé complètement le cycle primaire (15-17 ans)	NON UTILISÉ (pas disponible)
	Capacité de lecture et d'écriture	NON UTILISÉ	Enfant n'étant pas en capacité de lire et d'écrire (15-17 ans)
	Jeunes sans emploi ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation (NEET)	NON UTILISÉ	Enfant sans emploi ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation (NEET) (15-17 ans)

Source : Actualisation de l'étude sur la pauvreté et les disparités chez les enfants au Sénégal 2014 et EHCVM.

Les raisons expliquant le choix de dimensions et d'indicateurs différents sont expliquées ici.

- 8) **Différentes bases de données ont été utilisées.** Comme indiqué précédemment, l'analyse MODA actuelle est basée sur EHCVM 2018/2019, tandis que la MODA 2014 était basée sur EDS-MICS et ESPS. Les questionnaires utilisés, et donc les variables disponibles, dans chacune de ces enquêtes sont différents et les indicateurs qui peuvent être construits à partir de ces questions et variables le sont donc également limitant ainsi les possibilités de faire correspondre tous les indicateurs entre les deux exercices de mesure.
- 9) **Utilisation d'une unique base de données pour tous les groupes d'âge (0-17ans).** Cet exercice n'utilise que l'EHCVM pour mesurer la pauvreté de l'enfant indépendamment de son âge pour deux raisons principales. En premier lieu, cette approche permet la création d'une mesure combinée de pauvreté multidimensionnelle de l'enfant pour les 0-17 ans comme requis pour le suivi de la cible 1,2 des ODDs. Dans un deuxième temps, l'utilisation de l'EHCVM permet la réalisation d'une analyse de chevauchement entre la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective (les deux dernières mesurées au niveau du ménage de l'enfant), une analyse pertinente pour informer les risques d'exclusion liés au ciblage selon une approche particulière de la pauvreté.
- 10) **Décisions techniques quant à l'exclusion de certaines variables.** Les résultats préliminaires ont conduit à l'exclusion de certains indicateurs selon la méthodologie MODA. Par exemple, les indicateurs qui ne présentaient que peu de variance ou qui montraient une forte corrélation entre eux n'ont pas pu être inclus.
- 11) **Évolution de la définition de la pauvreté de l'enfant.** Le contexte 2018-2019 est différent de celui de 2011. Ainsi, les dimensions et les indicateurs retenus pour l'analyse de 2024, sur la base des données de 2018-2019, représente la situation actuelle.

Pour ces raisons, **les résultats des analyses MODA 2014 et 2024 ne sont pas comparables**. En effet, même si les deux études capturent la pauvreté multidimensionnelle, chacune de ces études utilise différents indicateurs, ce qui empêche d'effectuer une analyse des tendances. Le tableau ci-dessous montre les taux de privation pour chaque indicateur et chaque groupe d'âge pour les rapports 2014 et 2024. Il est cependant important de garder à l'esprit les définitions des indicateurs et les arguments mentionnés ci-dessus en effectuant d'éventuelles comparaisons.

Tableau 3. Taux de privation par indicateur pour les rapports sur la pauvreté 2014 et 2024.

Dimensions	Indicateurs	MODA 2014			MODA 2024		
		0-4 ans	5-14 ans	15-17 ans	0-4 ans	5-14 ans	15-17 ans
Logement	Structure du logement	44.6%	36.3%	60.3%			
	Surpeuplement du logement	15.0%	13.4%	11.2%	13.3%	12.7%	11.4%
	Débarras des ordures ménagères				59.3%	58.2%	53.0%
Eau	Sources d'approvisionnement en eau de boisson	24.1%	22.1%	19.9%	12.0%	10.7%	8.5%
	Temps pour aller chercher l'eau				17.7%	16.4%	13.9%
Assainissement	Type de sanitaire	44.5%	32.3%	28.5%	40.3%	39.1%	34.1%
	Partage des toilettes				20.4%	19.4%	18.6%
Nutrition	Poids/Taille	19.1%					
	Poids/Âge	28.4%					
	Taille/Âge	9.8%					
	Nombre de repas par jour		18.2%	16.2%			
	Insécurité alimentaire		20.8%	20.7%	45.0%	46.5%	44.9%
	Diversité des repas					47.8%	45.1%
Santé	Assistance en structure	27.3%					
	Assistance en personnel qualifié	23.3%					
	Vaccination	34.3%					
	Accès à une structure de santé publique		19.7%	17.1%	31.8%	78.5%	75.2%
	Combustible pour la cuisine				92.3%	92.3%	91.5%
Environnement sécuritaire / Protection de l'enfant	Environnement sécuritaire		12.3%	10.7%			
	Travail des enfants (économique et domestique)		11.6%			43.01%	
	Disponibilité de l'acte de naissance	37.1%			31.8%	30.1%	
	Enfant vivant avec ses parents biologiques				36.5%	41.8%	52.8%
Éducation	Fréquentation scolaire		36.2%			45.3%	
	Achèvement du primaire			43.6%			
	Capacité de lecture et d'écriture						28.1%
	Jeunes sans emploi ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation (NEET)						85.7%

Source : Actualisation de l'étude sur la pauvreté et les disparités chez les enfants au Sénégal 2014 et propres calculs à partir de l'EHCVM.

3. Résultats : Pauvreté de l'enfants au Sénégal (0-17 ans)



Les principaux résultats de l'étude de la pauvreté pour la population totale des enfants au Sénégal, c'est-à-dire ceux âgés de 0 à 17 ans, sont résumés dans cette section. Les caractéristiques des enfants préalablement identifiés comme pauvres ont été examinées afin d'établir des profils de pauvreté. Le chevauchement dans la prévalence de la pauvreté monétaire, multidimensionnelle et subjective est également analysé. L'analyse présentée dans cette section du rapport permet de répondre aux questions suivantes :

- Quelle est l'incidence et l'intensité de la pauvreté (multidimensionnelle, monétaire et subjective) de l'enfant au Sénégal ?
- Les trois approches à la pauvreté retenues identifient-elles les mêmes enfants comme étant pauvres ?
- Quel sont les profils de ces enfants pauvres (multidimensionnel, monétaire et subjectif) ?

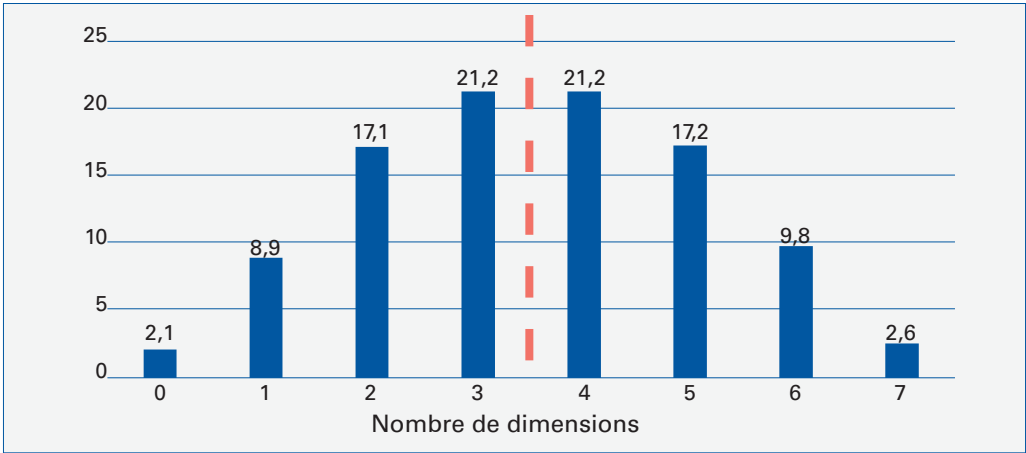
3.1. Enfants pauvres multidimensionnellement et leurs caractéristiques

La figure 1 fournit une analyse détaillée du nombre d'enfants âgés de 0 à 17 ans faisant face à la privation simultanée dans plusieurs dimensions. Presque tous les enfants du Sénégal (97,9%) souffrent de privation dans au moins une dimension. En effet, seul 2,1% des enfants du Sénégal ne souffrent d'aucune privation. Une proportion toute aussi élevée des enfants (89%) souffre de privation dans au moins 2 dimensions. Un peu moins de 3 enfants sur 4 (71,9%) subissent des privations dans au moins 3 dimensions. En outre, environ 9,8% et 2,6% des enfants souffrent respectivement de privations dans 6 et 7 dimensions de bien-être.

Afin d'atteindre la cible 1.2 de l'ODD 1, il faudrait réduire d'ici 2030 de moitié le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans la pauvreté multidimensionnelle. Afin de définir la pauvreté multidimensionnelle, la détermination d'un seuil identifiant les pauvres multidimensionnels est nécessaire. Selon la forme que prend la distribution du nombre de privation chez les enfants du Sénégal, il a été décidé d'adopter un seuil de pauvreté multidimensionnelle de $k=4$, selon lequel un enfant est considéré comme pauvre lorsqu'il subit au moins 4 privations³¹.

³¹ Cette définition de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant est sévère ne faisant pas ressortir les formes les plus modérées de privation multidimensionnelle. Cette approche permettra de mettre l'accent sur la situation des enfants faisant face aux situations les plus critiques lorsqu'il s'agit de leur bon développement.

Figure 1. Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans privés simultanément pour 0 à 7 dimensions



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Comme indiqué plus haut, un enfant est défini comme multidimensionnellement pauvre s’il subit des privations dans au moins 4 dimensions de bien-être. Pour ce seuil, les quatre indices suivants permettent de résumer la prévalence et l’intensité de la pauvreté multidimensionnelle. Le H, montre le pourcentage d’enfants pauvres (50,7%) alors que le A fait ressortir le nombre moyen de privations subis par les enfants pauvres multidimensionnels en valeur absolue (4,9) ou en pourcentage (72,2%) du nombre total des dimensions considérées pour l’analyse (jusqu’à 7 dimensions pour certains groupes d’âge). Finalement, le M0 montre l’indice de la prévalence ajusté (pour intensité) de la pauvreté multidimensionnelle : le produit de H et A en %, résultant en un indice sensible aussi bien à l’incidence qu’à l’intensité de la privation multidimensionnelle. Le M0 prend la valeur de 0,366 au Sénégal. Cette valeur n’a aucune signification si elle n’est pas comparée, elle pourra être mise en perspective lors de la comparaison des régions, du milieu de résidence ou en utilisant d’autres variables de profils.

Tableau 4. Prévalence, intensité et indice ajusté pour intensité de la pauvreté multidimensionnelle chez les enfants âgés de 0-17 ans pour un seuil de k=4

Indices	Valeurs nationales
Prévalence de la pauvreté multidimensionnelle (H), %	50,7
Intensité de privations chez ceux multidimensionnellement pauvres (A), %	72,2
Moyenne de privations chez ceux multidimensionnellement pauvres, intensité en valeur absolue (A)	4,9
L’indice de la prévalence de la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour intensité (M0)	0,366

Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

En ventilant les indices de pauvreté multidimensionnelle selon certaines caractéristiques des enfants, on voit apparaître des différences marquées. Ainsi, le taux de privation multidimensionnelle est plus élevé chez les enfants vivant en milieu rural (66,5 %) qu’en milieu urbain (28,1 %). Les enfants vivant dans un ménage dirigé par un homme sont les plus pauvres : 53,8 %, contre 40,4 % pour ceux dont le chef de ménage est une femme. Il serait intéressant d’examiner de plus près cette différence notable. En effet, dans la littérature, les ménages dirigés par un homme sont souvent moins pauvres. En outre, certaines études ont également révélé que le concept même de chef de ménage comporte des biais d’analyse³² Pour les enfants évoluant dans des familles dont le chef de ménage a déclaré une maladie les 30 jours précédant l’enquête EHCVM, il semblerait qu’ils soient moins pauvres (48,4%) que si le chef de ménage n’a pas déclaré de maladie (52.2%). Toutefois, le taux de pauvreté des enfants vivant dans un ménage ou le chef a au moins un diplôme d’études moyennes (14,2%) est moins élevé comparé à celui des enfants de ménage dont le chef a le niveau d’études CEP ou CFEE (32,8%) ou n’ayant aucun diplôme (55,9%). Les mêmes tendances sont observées pour l’intensité et l’indice de l’incidence de la privation multidimensionnelle ajusté.

32 Un certain nombre d’études ont contesté l’utilisation du chef de ménage comme catégorie analytique pertinente pour un certain nombre de raisons, notamment l’absence de définitions comparables des termes « ménage » et « chef de ménage » ; l’ambiguïté du terme « chef de ménage » lorsque l’attribution de la direction est laissée à l’appréciation des membres du ménage ; et le fait que le terme « chef de famille » ne reflète pas les conflits internes dans l’allocation des ressources. Voir : Buvinic, M. and G. Gupta. 1997. “Female-Headed Households and Female-Maintained Families: Are They Worth Targeting to Reduce Poverty in Developing Countries?” Economic Development and Cultural Change 45 (2): 259-280; Quisumbing, A., L. Haddad and C. Peña. 2001. “Are Women Overrepresented among the Poor? An Analysis of Poverty in 10 Developing Countries.” Journal of Development Economics 66 (1): 225-269

Tableau 5. *Prévalence, intensité et prévalence ajusté pour intensité de la pauvreté multidimensionnelle (k=4) chez les enfants âgés de 0-17 ans selon certaines caractéristiques*

Profil	Variables de profil	H, %	A, %	A	M0
National	National	50.7	72.2	4.9	0.366
Milieu de résidence	Urbain	28.1	66.5	4.5	0.187
	Rural	66.5	73.9	5.0	0.491
Sexe du chef de ménage	Masculin	53.8	72.8	4.9	0.392
	Féminin	40.4	69.7	4.7	0.282
Épisode de maladie lors des 30 derniers jours pour le chef de ménage	Oui	48.4	71.8	4.8	0.347
	Non	52.2	72.5	4.9	0.378
Diplôme plus élevé du chef de ménage	Études moyennes ou plus	14.2	64.4	4.4	0.091
	CEP/CFEE	32.8	69.8	4.7	0.229
	Aucun	55.9	72.6	4.9	0.406

Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

3.2. Enfants pauvres monétairement³³ et leurs caractéristiques

Le tableau 6 montre qu’au Sénégal, 43,3% des enfants âgés de 0 à 17 ans vivent au sein de ménages pauvres monétairement. Pour ce qui est de l’intensité ou du gap de pauvreté, la part de revenu moyen qu’il faut affecter aux enfants pauvres pour les ramener au niveau du seuil de pauvreté est de 12,1%. La sévérité de la pauvreté multipliée par cent est de 4,65. Cet indice considère l’inégalité parmi les pauvres en pondérant l’écart de pauvreté en fonction de lui-même, de manière à privilégier les personnes en situation d’extrême pauvreté.

Tableau 6. *Prévalence, intensité et sévérité de la pauvreté monétaire chez les enfants âgés de 0-17 ans pour le seuil absolu de pauvreté monétaire au Sénégal 333 440,5 FCFA*

Indices	Valeurs nationales
Prévalence de la pauvreté monétaire (FGT0 ou P0), %	43,3
Intensité ou gap de pauvreté monétaire (FGT1 ou P1), %	12,1
Sévérité ou écart de la pauvreté monétaire (FGT2 ou P2) x 100	4,65

Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Le tableau suivant montre le résultat d’analyses désagrégées selon certaines caractéristiques des enfants : leur milieu de résidence et le sexe, l’état de santé durant les 30 derniers jours et le niveau d’éducation du chef de ménage. Au Sénégal, les enfants vivant en milieu rural sont relativement plus nombreux à faire face à la pauvreté monétaire (56,7%) comparés aux enfants vivant en milieu urbain (24,1%). Pour ce qui est des caractéristiques du chef des ménages au sein desquels les enfants pauvres monétairement vivent, l’analyse fait ressortir que les enfants des ménages avec un chef de ménage de sexe masculin ou n’ayant pas été malade ou n’ayant aucun diplôme sont les plus pauvres (48,3%, 46,6% et 47,6% respectivement). La même tendance est observée en analysant les mesures d’intensité et de sévérité de la pauvreté.

33 La pauvreté monétaire est mesurée au niveau du ménage. Pour les besoins de cette étude, un enfant est considéré comme pauvre monétaire s’il fait partie d’un ménage pauvre monétairement. Les indices de pauvreté monétaire pour les enfants âgés de 0 à 17 ans sont pondérés selon le nombre d’enfants dans le ménage, c’est-à-dire que le dénominateur est constitué de tous les enfants de la population d’intérêt.

Tableau 7. Prévalence, intensité et sévérité de la pauvreté monétaire (333 440,5 FCFA) chez les enfants âgés de 0-17 ans selon certaines caractéristiques

Profil	Variables de profil	FGT0 ou P0, %	FGT1 ou P1 %	FGT2 ou P2 x 100
National	National	43.3	12.1	4.65
Milieu de résidence	Urbain	24.1	5.82	2.13
	Rural	56.7	16.5	6.41
Sexe du chef de ménage	Masculin	48.3	13.8	5.38
	Féminin	26.7	6.3	2.2
Épisode de maladie lors des 30 derniers jours pour le chef de ménage	Oui	38	10.1	3.74
	Non	46.6	13.3	5.2
Diplôme plus élevé du chef de ménage	Études moyennes ou plus	14.2	3.09	0.948
	CEP/CFEE	27.2	5.83	1.94
	Aucun	47.6	13.5	5.26

Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

3.3. Pauvreté subjective des enfants³⁴ et leurs caractéristiques

Les enfants appartenant à des ménages où le répondant indique en réponse à la question “Quelle est la perception du niveau de vie du ménage sur une échelle de bien-être allant de 1-4 ?” que son ménage est “pauvre” ou très pauvre sont considérés comme pauvres subjectivement. Le tableau suivant montre que 53,5% et 7,9% des enfants âgés de 0 à 17 ans au Sénégal vivent dans des ménages se sentant pauvre et ou très pauvres.

Tableau 8. *Prévalence de la pauvreté subjective (modérée et extrême) chez les enfants âgés de 0-17 ans, %*

Indices	Valeurs nationales
Prévalence de la pauvreté subjective	53,5
Prévalence de la pauvreté subjective extrême	7,9

Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Le tableau suivant montre que le niveau de pauvreté subjective est plus élevé dans les ménages vivant en milieu rural (59,8% contre 44,6%), ou avec un chef de ménage de sexe masculin (55,3% contre 47,5%) ou avec un chef de ménage ayant déclaré être malade lors des 30 derniers jours (55,0% contre 52,7%) ou un chef de ménage n’ayant aucun diplôme (57,1% contre 45,9% et 24,7%). Les mêmes tendances sont constatées pour la pauvreté subjective extrême.

Profil	Variables de profil	Pauvre subjectif, %	Pauvre subjectif extrême, %
National	National	53.5	7.9
Milieu de résidence	Urbain	44.6	4.7
	Rural	59.8	10.2
Sexe du chef de ménage	Masculin	55.3	8.5
	Féminin	47.5	5.9
Épisode de maladie lors des 30 derniers jours pour le chef de ménage	Oui	55.0	8.4
	Non	52.7	7.7
Diplôme plus élevé du chef de ménage	Études moyennes ou plus	24.7	1.9
	CEP/CFEE	45.9	3.8
	Aucun	57.1	8.9

Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

34 La pauvreté subjective est mesurée au niveau du ménage selon la réponse d’un membre du ménage au module pauvreté subjective et perceptions de la pauvreté de l’EHCVM. Pour les besoins de cette étude, un enfant est considéré comme pauvre subjectif s’il fait partie d’un ménage pauvre subjectif. Un ménage est considéré comme pauvre subjectif si le répondant indique en réponse à la question “Quel est la perception du niveau de vie du ménage sur une échelle de bien-être allant de 1-4?” que son ménage est pauvre ou très pauvre. Les ménages ayant répondu s’estimé “très pauvres” sont considérés comme étant en extrême pauvreté subjective.

3.4. Pauvreté monétaire, multidimensionnelle et subjective des enfants et leurs caractéristiques

L'un des objectifs de cette étude est d'analyser l'étendue du croisement des trois approches de la pauvreté dans l'identification des mêmes enfants comme pauvres. Avant de passer à l'analyse, le tableau et la figure suivantes résument le niveau de prévalence de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective chez les enfants âgés de 0-17 ans selon le milieu et la région de résidence.

Au niveau national, la prévalence de la pauvreté subjective touche 53,5% des enfants contre 50,7% et 43,3% pour la pauvreté multidimensionnelle et monétaire respectivement. En se concentrant sur les enfants évoluant en milieu urbain, une baisse généralisée de la prévalence des trois types de pauvreté est observée : la pauvreté subjective et multidimensionnelle touchant cependant un pourcentage plus important d'enfants. En milieu rural, le taux de prévalence de la pauvreté multidimensionnelle (66,5%) dépasse ceux de la pauvreté subjective (59,8%) et monétaire (56,7%). Cela montre le besoin d'étudier les déterminants de la pauvreté monétaire, subjective et multidimensionnelle en contrôlant l'effet des zones de résidences.

Tableau 9. Prévalence de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective chez les enfants âgés de 0-17 ans selon le milieu de résidence, %

Indices	Valeurs nationales	Urbain	Rural
Prévalence de la pauvreté multidimensionnelle (H), %	50,7	28,1	66,5
Prévalence de la pauvreté monétaire (FGT0 ou P0), %	43,3	24,1	56,7
Prévalence de la pauvreté subjective, %	53,5	44,6	59,8

Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Les figures suivantes cartographient la prévalence de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective chez les enfants âgés de 0 à 17 ans dans les 14 régions administratives du Sénégal.

La pauvreté multidimensionnelle est plus élevée dans les régions de Kédougou (82,1%), Kolda (79,4%) et Sédhiou (78%) et plus basse dans celles de Diourbel (42,9%), Thiès (38%) et Dakar (18%), avec une différence de 20 points de pourcentage entre les deux dernières régions. Cette figure montre que Dakar se distingue des autres régions avec une prévalence beaucoup plus basse de privations dans 4 ou plus de dimensions de bien-être chez les enfants.

Figure 2. Prévalence de la pauvreté multidimensionnelle chez les enfants âgés de 0-17 ans selon la région de résidence, %

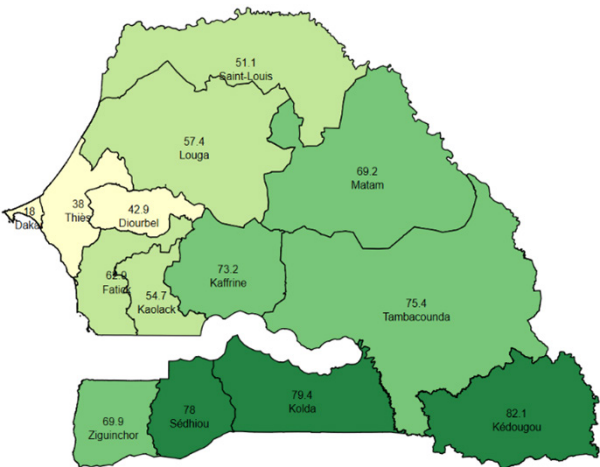
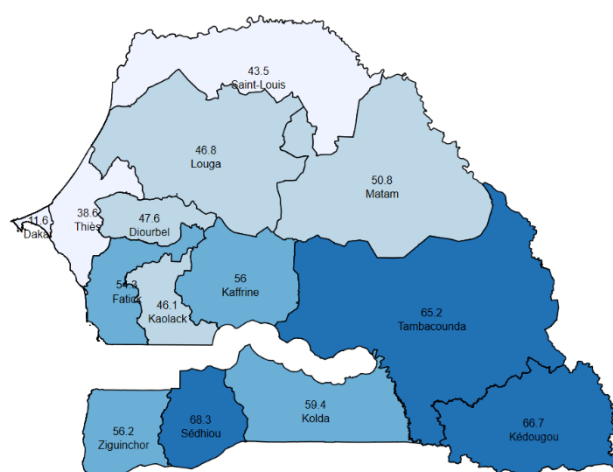


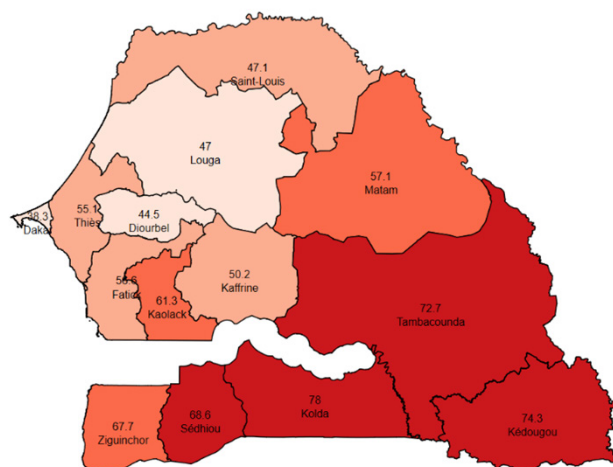
Figure 3. Prévalence de la pauvreté monétaire (FGT0 ou P0) chez les enfants âgés de 0-17 ans selon la région de résidence, %

En analysant cette fois la prévalence de la pauvreté monétaire chez les enfants de 0 à 17 ans, ce sont toujours les régions de Sédhiou (68,3%) et Kédougou (66,7%) qui ont les taux les plus élevés de pauvreté. Dakar a toujours la prévalence la plus basse, à 11,6%, suivi de Thiès (38,6%) et de Saint-Louis (43,5%).



Pour ce qui est de la prévalence de la pauvreté subjective chez les enfants de 0 à 17 ans, la tendance reste la même. Les plus fortes prévalences sont observées à Kolda (78%), Kédougou (74,3%), Tambacounda (72,7%) et Sédhiou (68,6%) et les plus basse à Dakar (18,3%), Diourbel (44,5%) et Louga (47%).

Figure 4. Prévalence de la pauvreté subjective chez les enfants âgés de 0-17 ans selon la région de résidence, %



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

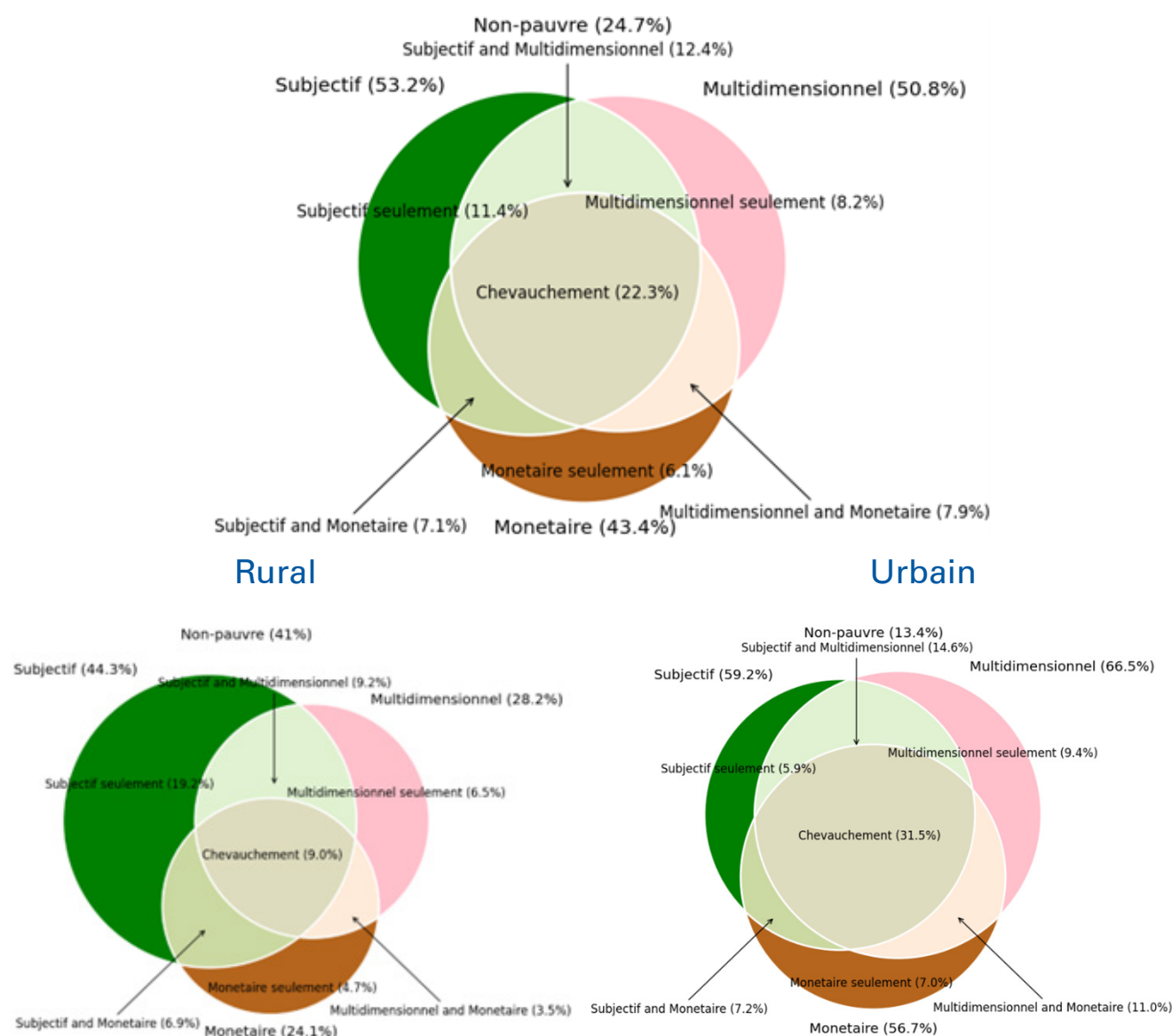
La figure 5 montre des diagrammes de Venn illustrant le chevauchement entre la prévalence de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective chez les enfants âgés de 0 à 17 ans au Sénégal au niveau national ainsi qu'aux niveaux urbain et rural.

Au Sénégal, 34,7% (somme de 12,4% et 22,3%) des enfants sont pauvres subjectivement et multidimensionnellement ; 12,4% sont seulement pauvres subjectivement et multidimensionnellement et 22,3% sont pauvres pour les trois définitions. Les résultats révèlent également que, 30,2% sont pauvres multidimensionnels et monétaire et 29,4% sont pauvres monétaire et subjectifs. Cette dernière catégorie représente une part assez importante de la population des enfants (un peu moins d'un quart). Toutefois, ces résultats font ressortir que centrer des politiques au profit d'enfants pauvres sur une définition seulement de la pauvreté en exclurait d'autres faisant face à d'autres formes toutes aussi

PAUVRETÉ DE L'ENFANT AU SENEGAL

légitimes de pauvreté. Par exemple, un programme de cantines scolaires au profit des enfants de ménages pauvres monétaires exclurait 20,6% d'enfants subissant 4 ou plus de privations et 23,8% de ménages pensant être pauvres. Ce constat est d'autant plus important en milieu urbain où le chevauchement entre les 3 types de pauvreté est encore plus bas (9%). Malgré un pourcentage important d'enfants non pauvres ces trois définitions (41%), les enfants pauvres vivant en milieu urbain semblent montrer des profils de pauvreté (multidimensionnelle, monétaire ou subjective) très différents. La tendance opposée est observée en milieu rural où un plus grand nombre d'enfants est pauvre pour au moins une des trois définitions (86,6%). Le chevauchement entre les 3 types de pauvreté s'élève à 31,5% en milieu rural.

Figure 5. Chevauchement de la prévalence des trois types de pauvreté chez les enfants âgés de 0-17 ans : monétaire, multidimensionnelle et subjective, %



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

4. Analyse du Chevauchement des Privations multiples par cycle de vie

La MODA adopte une approche holistique de la pauvreté et des privations et permet l'analyse des multiples facettes du bien-être des enfants pour différents groupes d'âge. L'approche utilisée du cycle de vie veut que la définition de la privation évolue avec l'âge de l'enfant. Un enfant de 5 mois devra être allaité au sein alors qu'un enfant de 17 ans devra être à l'école pour ne pas être privé. Dans le cadre de ces approches, les analyses suivantes ont été réalisées pour chacun des trois groupes d'âge (0-4 ans, 5-14 ans et 15-17 ans).

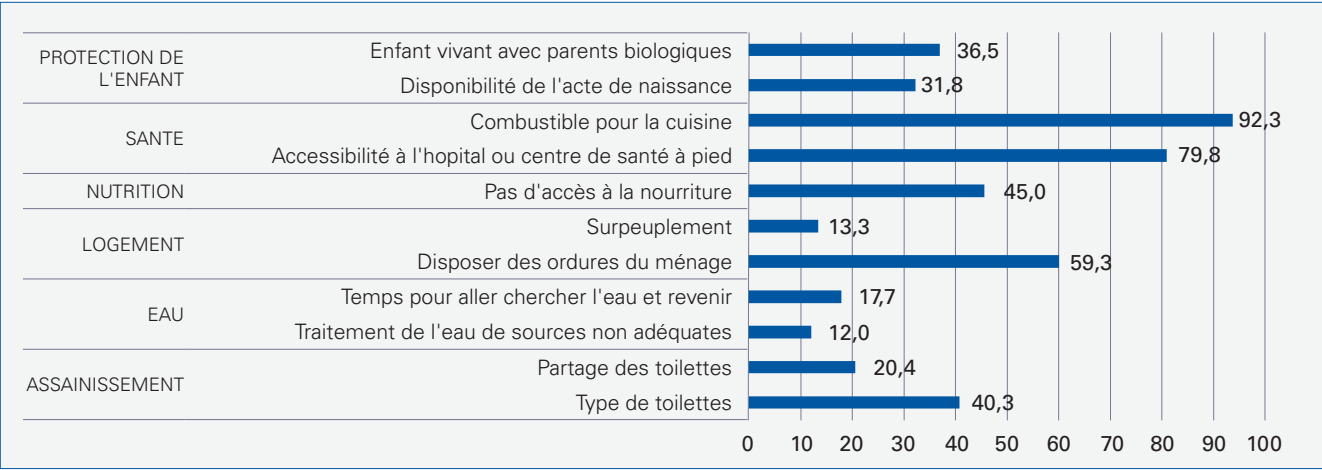
- 12) l'analyse unidimensionnelle des privations qui se focalise sur les secteurs les plus pertinents de la privation des enfants
- 13) l'analyse multidimensionnelle des privations qui montre et analyse le compte des privations subies simultanément par chaque enfant
- 14) l'analyse du chevauchement de la privation multidimensionnelle qui permet d'illustrer et d'analyse pour quelle(s) combinaison(s) de dimensions les enfants sont privés simultanément. Ce type d'analyse permet d'évaluer la pertinence de réponses programmatiques multisectorielles à la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant.

Enfants âgés de 0-4 ans

Analyse unidimensionnelle de la privation

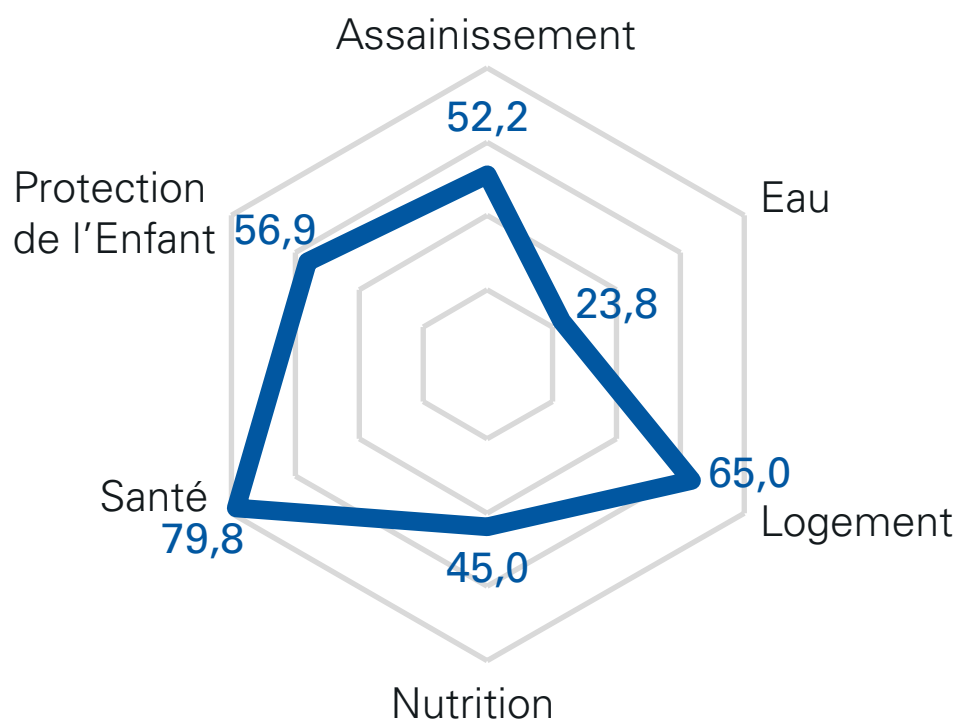
Pour les enfants de 0 à 4 ans, la plus grande privation observée concerne l'utilisation de combustibles de cuisson solides³⁵ et l'accessibilité, à pied, à une structure de santé (voir figure 6). En effet, 92,3% des enfants vivent dans un ménage qui utilise des combustibles solides et donc dangereux pour la santé et 79,3% des enfants n'ont pas un accès à pied à une structure de santé. Ensuite, 59,3% des enfants de moins de 5 ans vivent dans des ménages où l'évacuation des ordures ménagères pose un problème sans compter que presque la moitié des enfants de 0 à 4 ans n'a pu se nourrir à sa faim. Enfin en ce qui concerne l'assainissement, pour 40,3% des enfants de ce groupe d'âge disposent d'un type de toilettes inadéquat. En outre, 20,4% de ces enfants vivent dans des ménages qui partagent les toilettes avec au moins un autre ménage. Les taux de privation les plus importants sont observés pour les dimensions de la Santé (79,8%) et du Logement (65%), après avoir écarté l'indicateur « combustible pour la cuisine ». En revanche, la privation dans la dimension « Eau » concerne moins du quart des enfants de cette tranche d'âge.

Figure 6. Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés par indicateur et par dimension



35 L'indicateur « combustible pour la cuisine » n'a pas été retenu pour l'analyse par dimension et multidimensionnelle pour cause de variance insuffisante mais celui-ci reste inclus dans l'analyse unidimensionnelle car il reste pertinent.

Figure 7. Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés par dimension au niveau national et milieu de résidence



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

En plus d'identifier les indicateurs et les dimensions pour lesquels les enfants âgés de 0 à 4 ans sont privés, il est pertinent de comprendre le profil des enfants qui sont les plus défavorisés. Pour chaque dimension, les enfants vivant dans les zones rurales sont plus privés par rapport aux enfants vivant dans les zones urbaines. La plus grande différence étant observée pour les dimensions de l'eau et du logement, avec une différence de 267% (24 pp) et 124% (46pp), respectivement, par rapport aux taux observés en milieu urbain. Les taux de privation varient également selon les régions. Dans les régions de Sédhiou, Kédougou et Kolda, les taux de privation sont parmi les plus élevés, tandis que Dakar, Thiès et Diourbel représentent les régions avec les taux les plus faibles.

Il est en outre possible d'observer des différences de privation en fonction des caractéristiques du chef de ménage dans lequel vit l'enfant. Par exemple, les enfants des ménages dont le chef est un homme éprouvent davantage de privations, à l'exception de la dimension de la protection de l'enfance. Les résultats montrent clairement que les enfants dont le chef de famille n'a pas fait d'études sont moins nantis. Ceci est moins évident pour la dimension Santé avec des taux de privations qui varient peu entre 73,8% et 80,8%.

De manière similaire, les caractéristiques du logement tels qu'une source d'eau adéquate ou des matériaux adéquats semblent être corrélés aux taux de privation pour plusieurs dimensions. Les enfants n'ayant pas de source d'éclairage ou de matériaux adéquats pour le logement, subissent ainsi plus de privations. Dans le domaine de la santé, la différence est moins marquée. Cette absence de différence peut s'expliquer par le taux de privation généralement élevé pour la dimension santé.

Tableau 10. *Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés par dimension selon certaines caractéristiques*

	Profil	Assainisse- ment	Eau	Logement	Nutrition	Santé	Protection de l'Enfant
National	National	52,2	23,8	65,0	45,0	79,8	56,9
Milieu de résidence	Urbain	35,3	8,5	37,0	36,0	72,9	45,7
	Rural	62,8	33,5	82,6	50,7	84,2	63,9
Région	Sedhiou	93,7	55,3	76,4	74,1	87,3	61,2
	Kedougou	93,5	51,7	87,8	69,3	86,7	45,1
	Kaffrine	70,3	14,7	88,3	48,6	92,0	56,6
	Matam	62,7	32,5	89,4	66,5	65,2	71,4
	Kolda	87,5	51,5	78,3	73,5	89,9	45,9
	Fatick	49,8	35,9	87,1	49,8	81,5	60,5
	Louga	41,3	29,9	81,8	53,5	82,5	65,8
	Thies	30,3	18,7	57,0	33,2	84,1	55,2
	Kaolack	59,0	15,9	69,6	37,4	81,0	57,5
	Tam- bacounda	82,6	47,4	80,4	64,5	85,3	54,1
	Saint-Louis	49,2	25,9	71,4	52,7	67,5	59,2
	Diourbel	42,1	11,5	60,4	34,5	82,9	76,4
	Ziguinchor	79,1	49,6	83,9	28,9	92,2	47,8
	Dakar	31,3	3,1	25,9	30,3	69,9	40,1
Sexe chef du ménage	Masculin	56,7	27,5	69,4	46,8	81,3	51,0
	Féminin	36,1	10,7	49,5	38,6	74,7	78,0
Diplôme plus élevé du chef de ménage (3 catégories)	Études moyennes ou plus	22,0	5,2	30,0	18,4	74,9	38,1
	CEP/CFEE	42,4	14,2	46,4	45,0	73,8	41,0
	Aucun	55,9	26,4	69,9	47,5	80,8	60,1
Source d'éclairage adéquate	Oui	39,4	13,4	54,4	34,8	77,9	52,6
	Non	79,6	46,1	87,7	66,9	84,3	66,0
Matériaux adéquats pour les murs, toit et sols	Non	64,3	33,1	78,1	53,1	83,8	60,7
	Oui	28,9	5,9	39,7	29,4	72,5	49,5

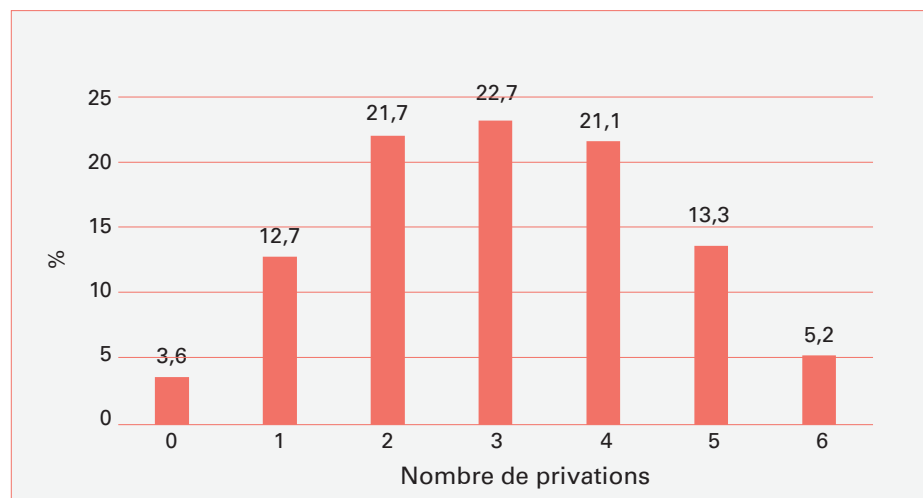
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Note : Différences statistiquement significatives pour un test de χ^2 ($p < 0.05$)

Analyse multidimensionnelle de la privation

La figure 8 montre la distribution des privations par dimension, en indiquant le pourcentage d'enfants confrontés à exactement 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 privations. Seuls 3,6% des enfants âgés de 0 à 4 ans au Sénégal ne sont pas privés dans aucune des six dimensions considérées pour l'analyse, tandis que la majorité souffre de privations multiples. Plus de la moitié des enfants sont simultanément confrontés à deux, trois ou quatre privations (65,3%). Environ 5,2 % des enfants moins de 5 ans souffrent de privations dans les six dimensions à la fois.

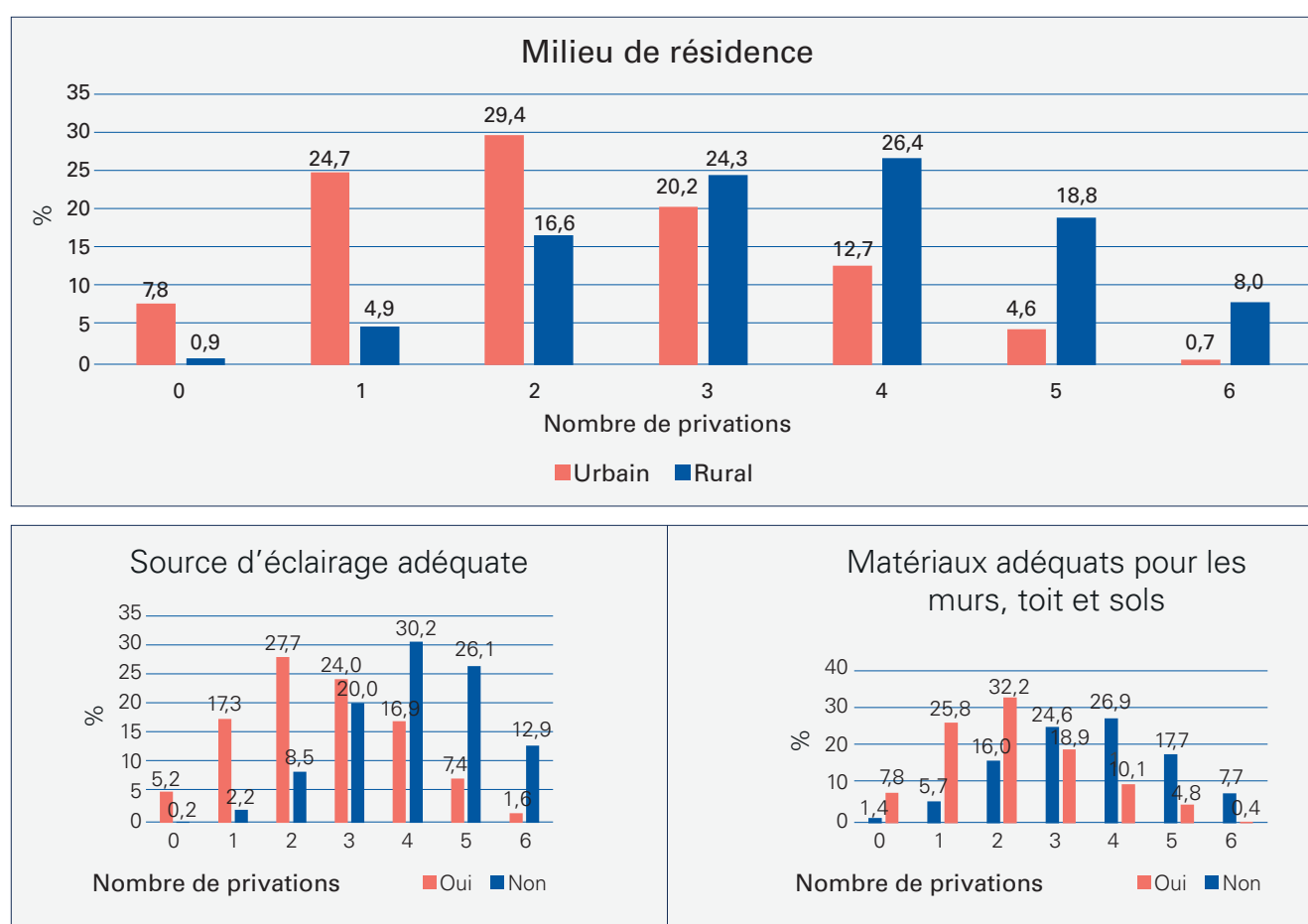
Figure 8. Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés simultanément pour 0 à 6 dimensions



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Dans la figure 9 ci-dessous, la distribution des privations est ventilée par milieu de résidence, source d'éclairage utilisée et matériaux pour les murs, toit et sols adéquats. La distribution pour le milieu urbain est axée vers la gauche alors que la distribution pour le milieu rural est plutôt axée vers la droite. Cela indique que le taux de privation dans les zones urbaines est plus faible que dans les zones rurales. En ce qui concerne la source d'éclairage, la distribution des enfants privés est plus orientée vers la droite par rapport aux enfants non privés, ce qui signifie aussi que les enfants vivant dans un ménage dont la source d'éclairage est inadéquate seront plus privés multidimensionnellement. Le même constat s'applique aux matériaux des murs, du toit et du sol.

Figure 9. Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés simultanément pour 0 à 6 dimensions selon certaines caractéristiques



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

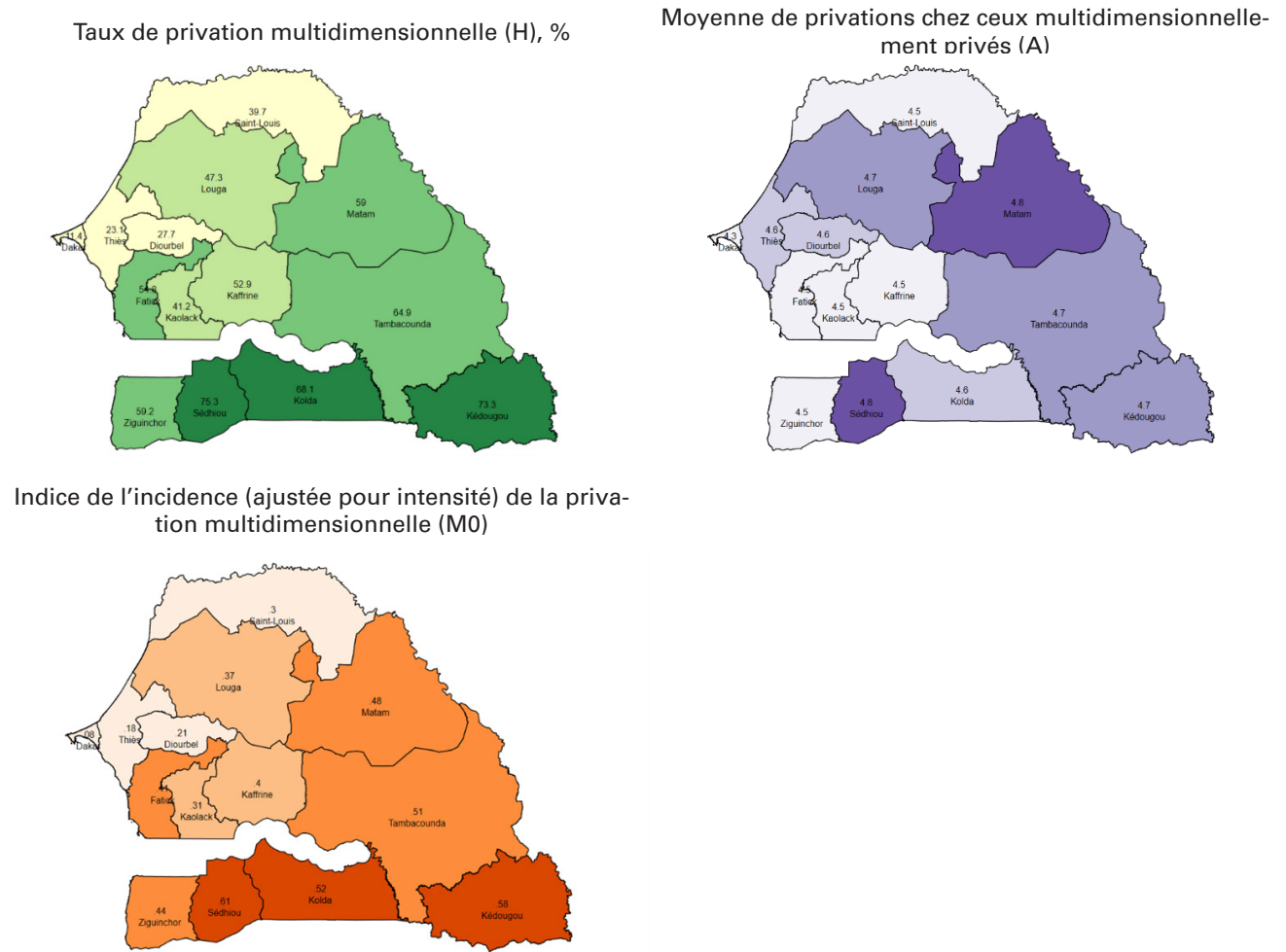
Le tableau 11 présente les indices de pauvreté multidimensionnelle des enfants selon un seuil de quatre privations. Le taux d'incidence de la privation multidimensionnelle (H) sert à calculer l'incidence des enfants multidimensionnellement pauvres au Sénégal. Comme illustré ci-dessous, 39,7 % des enfants de moins de 5 ans subissent des privations dans au moins quatre dimensions à la fois. La moyenne des privations subies par les enfants multidimensionnellement pauvres (A) représente le nombre moyen de privations auxquelles sont confrontés ces enfants en chiffres absolus. En moyenne, les enfants de 0 à 4 ans en situation de pauvreté multidimensionnelle connaissent des privations dans 4,6 dimensions à la fois. Cette moyenne est présentée en pourcentage du nombre total de dimensions considérés pour l'analyse (A en %). Enfin, l'indice de l'incidence (ajustée pour l'intensité) de privation multidimensionnelle (M0) prend en compte à la fois la prévalence et l'intensité de la privation ; il est le produit de H et A en % et prend des valeurs allant de 0 à 1. Bien que cet indice ne puisse être interprété seul, M0 peut être utilisé pour comparer des groupes de population et des régions géographiques, 0 représentant l'absence de privation et 1, un niveau de privation plus élevé. Au Sénégal, le M0 est de 0,30 au niveau national. Les zones rurales indiquent des niveaux de privation multidimensionnelle plus élevés, avec un M0 de 0,41 contre 0,13 dans les zones urbaines.

Tableau 11. Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 0-4 ans avec K=4

	Taux de privation multidimensionnelle (H), %	Moyenne de privations chez ceux multidimensionnellement privés (A)	Indice de l'incidence (ajustée pour intensité) de la privation multidimensionnelle (M0)
National	39,7	4,6	0,30
Rural	53,3	4,7	0,41
Urbain	17,9	4,3	0,13

La Figure 10 illustre les différences régionales en termes de taux de privation et l'incidence. La ville de Dakar est la mieux placée aussi bien en matière d'incidence que d'intensité de la privation multidimensionnelle, avec un indice M0 de 0,08, contre 0,61 pour Sédhiou et 0,58 pour Kédougou. Le sud-est du pays est plus pauvre que le reste du pays, y compris Dakar et les régions voisines.

Figure 10. Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 0-4 ans avec K=4, par région

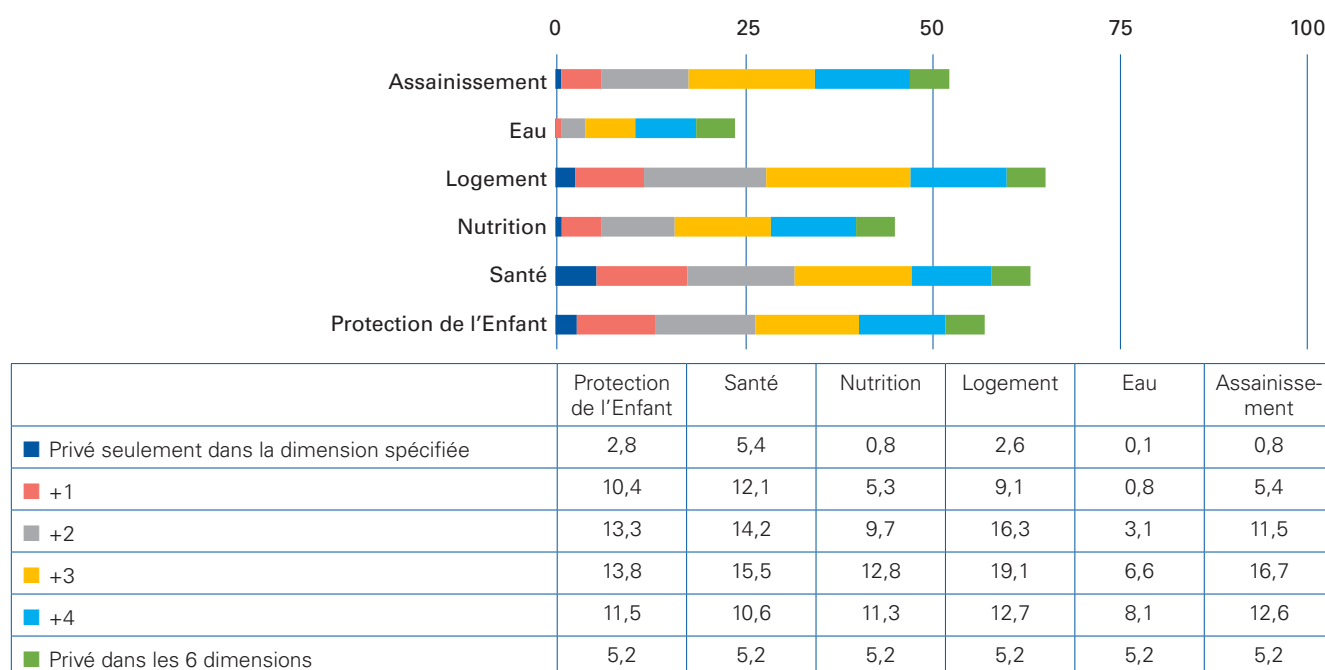


Analyse du chevauchement de la privation multidimensionnelle

Chevauchement par dimension

Le chevauchement des privations selon les dimensions confirme que très peu d'enfants sont privés dans une seule dimension à la fois, quelle que soit la dimension considérée (voir figure 6). Par exemple, 52,2 % des enfants âgés de moins de 5 ans sont privés dans la dimension Assainissement. Toutefois, ce sont 16,7 % des enfants de ce groupe d'âge qui connaissent des privations dans la dimension de l'Assainissement et d'en trois autres dimensions du bien-être. En revanche, seuls 0,8 % des enfants sont privés uniquement dans la dimension Assainissement (figure 11). Des résultats similaires sont observés pour toutes les dimensions. Ceci prouve donc que les privations ont tendance à être multidimensionnelles.

Figure 11. Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés dans une dimension spécifiée et dans 1, 2, 3, 4, 5 autres



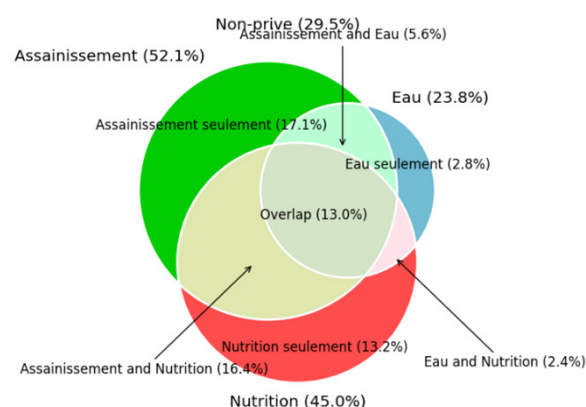
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Chevauchement sur trois dimensions

L'analyse du chevauchement des privations permet d'identifier les combinaisons de dimensions pour lesquelles des réponses multisectorielles sont les mieux adaptées. Trois combinaisons sont présentées dans ce rapport faisant ressortir le lien entre des dimensions ayant trait à la survie, au développement et à la protection des enfants de différents âges.

Le diagramme de Venn (figure 12), fournit les informations à propos de la privation dans les dimensions de l'assainissement, de l'eau et de la nutrition uniquement. Plus spécifiquement il est possible d'observer (1) les taux de privation pour chaque dimension séparément : 2,8% des enfants sont privés dans la dimension eau uniquement, 17,1% dans l'assainissement uniquement, et 13,2% pour la nutrition uniquement; (2) le chevauchement de privations entre deux dimensions: par exemple, la privation chevauchée entre la nutrition et l'assainissement est de 29,4% (total de 16,4% et de 13,0%) ; (3) le chevauchement de privations entre toutes les dimensions : 13% ; et (4) la proportion d'enfants qui ne sont privés dans aucune des dimensions montrées dans ce diagramme : 29,5% des enfants de moins de 5 ans.

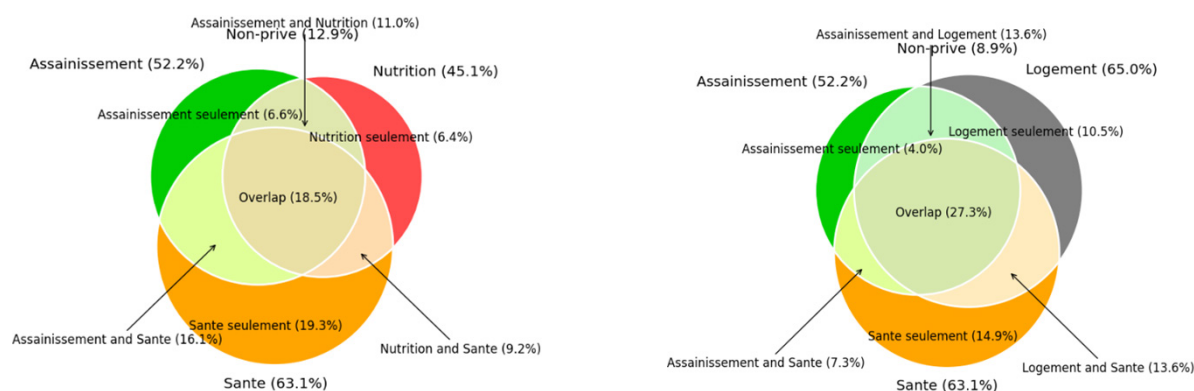
Figure 12. Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés simultanément pour l'assainissement, l'eau et la nutrition



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Dans la figure 13, les chevauchements entre d'autres combinaisons de dimensions peuvent être observés. Le premier diagramme de Venn montre que 18,5% des enfants de 0 à 4 ans sont privés dans trois dimensions simultanément ; la nutrition, la santé et l'assainissement. Plus de la moitié (54,8%) des enfants de 0 à 4 ans subit des privations simultanées dans au moins deux des dimensions. Cependant, 12,9% des enfants de ce groupe d'âge ne souffrent d'aucune privation dans ces trois dimensions. Le deuxième diagramme permet d'analyser les chevauchements entre l'assainissement, le logement et la santé. Le pourcentage d'enfants privés dans les trois dimensions est de 27,3%. Ce taux est élevé en comparaison avec les autres diagrammes. En matière d'élaboration des politiques, cela signifie que cibler simultanément ces trois domaines aurait un impact sur les enfants les plus vulnérables de 0 à 4 ans.

Figure 13. Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés simultanément pour une sélection de 3 dimensions



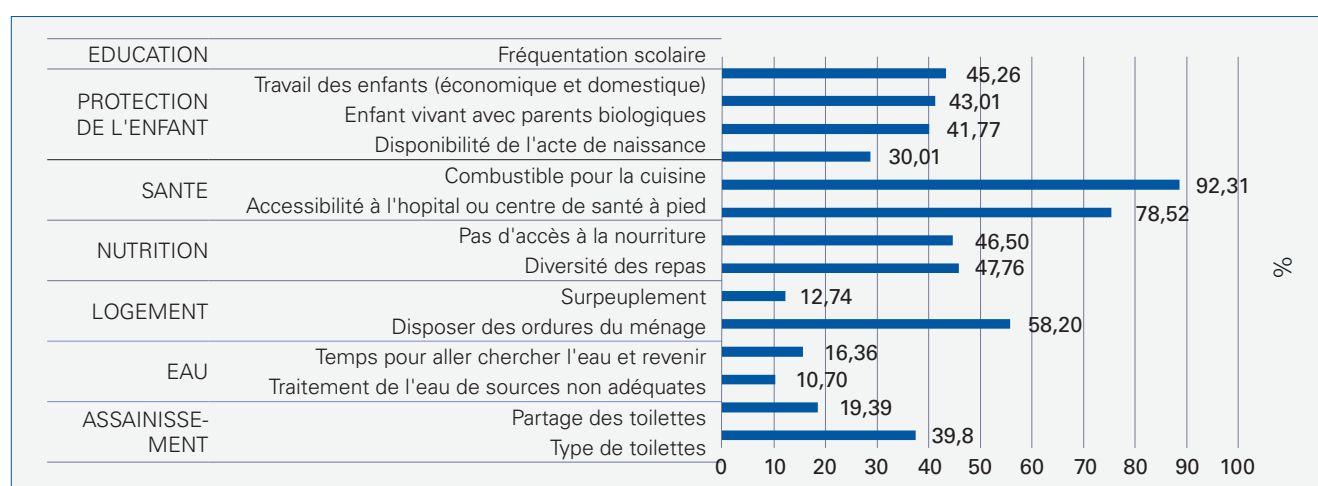
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Enfants âgés de 5-14 ans

Analyse unidimensionnelle de la privation

Pour les enfants de 5 à 14 ans, la plus grande privation est observée dans les deux indicateurs de la dimension santé (voir figure 14), comme pour les enfants de moins de 5 ans. 92,3% des enfants vivent dans un ménage qui utilise des combustibles³⁶ nocifs pour la santé et 78,5% des enfants n'ont pas accès à pied à une structure de santé, suivi par l'évacuation des ordures ménagères qui n'est pas adéquate pour 58,2% des enfants de 5 à 14 ans. La dimension nutrition révèle des taux également haut de 46,5% pour ce qui est de l'accès à la nourriture et 47,8% pour la diversité des repas. Le taux de privation dimensionnelle pour la nutrition est toutefois de 67% (voir figure 14) car l'approche de l'union utilisée pour agréger les indicateurs sous les dimensions veut qu'un enfant soit privé au niveau de la dimension dès lors qu'il ou elle est privé pour au moins un indicateur. Ce taux montre donc qu'une partie importante des enfants de 5 à 14 ans sont privés dans les deux indicateurs à la fois.

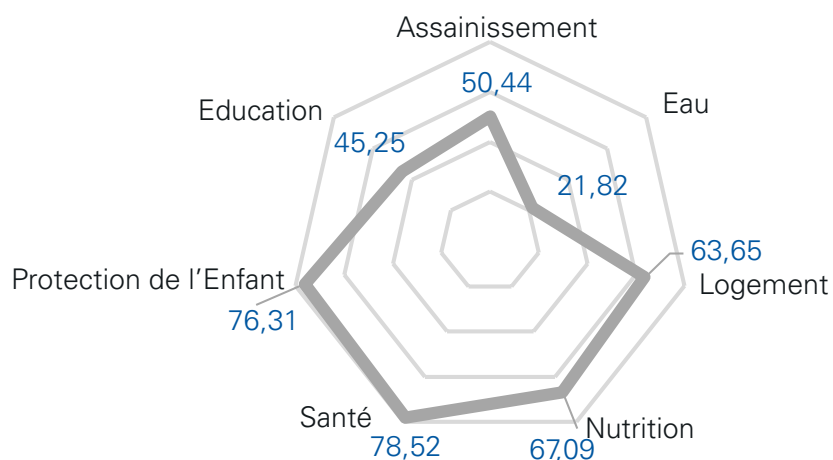
Figure 14. Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés par indicateur et par dimension



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

La figure 15 permet d'identifier le taux de privations pour chaque dimension. Les enfants de 5 à 14 ans sont ceux qui présentent le taux de privation le plus élevé dans les dimensions Santé (78,5 %) et Protection de l'enfant (76,3 %). Cependant, la privation dans la dimension eau concerne seulement 21,8 % des enfants de cette tranche d'âge.

Figure 15. Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés par dimension au niveau national



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Le tableau suivant illustre les différences entre le milieu urbain et le milieu rural. Une plus grande vulnérabilité est ob-

³⁶ L'indicateur « combustible pour la cuisine » n'a pas été retenu pour l'analyse par dimension et multidimensionnelle pour cause de variance insuffisante mais celui-ci reste inclus dans l'analyse unidimensionnelle car il reste pertinent.

servée chez les enfants vivant en milieu rural. Pour les dimensions de la santé et de la protection de l'enfant, les dimensions avec les plus hauts taux totales, la différence entre le milieu urbain et rural sont faibles. Ceci n'est pas le cas pour les autres dimensions. Le tableau résume les taux de privations par dimension et selon d'autres caractéristiques de l'enfant ou du chef de ménage. Les enfants les plus défavorisés ont les caractéristiques suivantes. Ils vivent en milieu rural, sont pour la plupart une fille mariée ou en union, ne sont pas couverts par une assurance maladie, ont un chef de ménage de sexe masculin ou pas diplômé, ou encore, vivent dans un ménage sans éclairage adéquat ou dans un logement fait en matériaux rudimentaires (non adéquats).

Tableau 12. *Pourcentage d'enfants âgés de 0-4 ans privés par dimension selon certaines caractéristiques*

	Profil	As-sainissement	Eau	Logement	Nutrition	Santé	Protection de l'Enfant	Éducation
National	National	50,44	21,82	63,65	67,09	78,52	76,31	45,26
Milieu de résidence	Urbain	35,08	8,30	35,46	56,52	73,90	71,42	28,26
	Rural	60,89	31,01	82,81	74,28	81,80	79,64	56,81
Mariage des enfants (filles)	Mariée	75,78	43,26	85,66	72,56	91,71	100,00	85,00
	Non-mariée	50,38	21,77	63,60	67,08	78,49	76,26	45,16
Couverture maladie	Couvert	18,15	3,36	17,10	23,70	81,71	47,45	11,49
	Non couvert	51,43	22,39	65,08	68,42	78,41	77,20	46,29
Sexe chef du ménage	Masculin	54,41	25,07	68,42	68,76	79,47	71,46	47,23
	Féminin	37,02	10,84	47,54	61,46	75,47	92,73	38,57
Diplôme plus élevé du chef de ménage (3 catégories)	Études moyennes ou plus	22,84	5,31	29,41	42,39	76,13	60,96	12,09
	CEP/CFEE	37,00	12,48	47,16	58,20	74,91	70,44	23,42
	Aucun	54,30	24,24	68,42	70,29	79,06	78,33	50,37
Source d'éclairage adéquate	Oui	37,95	12,50	53,07	59,19	76,90	73,61	38,05
	Non	78,82	42,98	87,68	85,03	82,76	82,44	61,62
Matériaux adéquats pour les murs, toit et sols	Non	62,88	30,50	76,84	76,13	81,91	78,92	51,98
	Oui	27,64	5,91	39,47	50,52	72,80	71,53	32,93

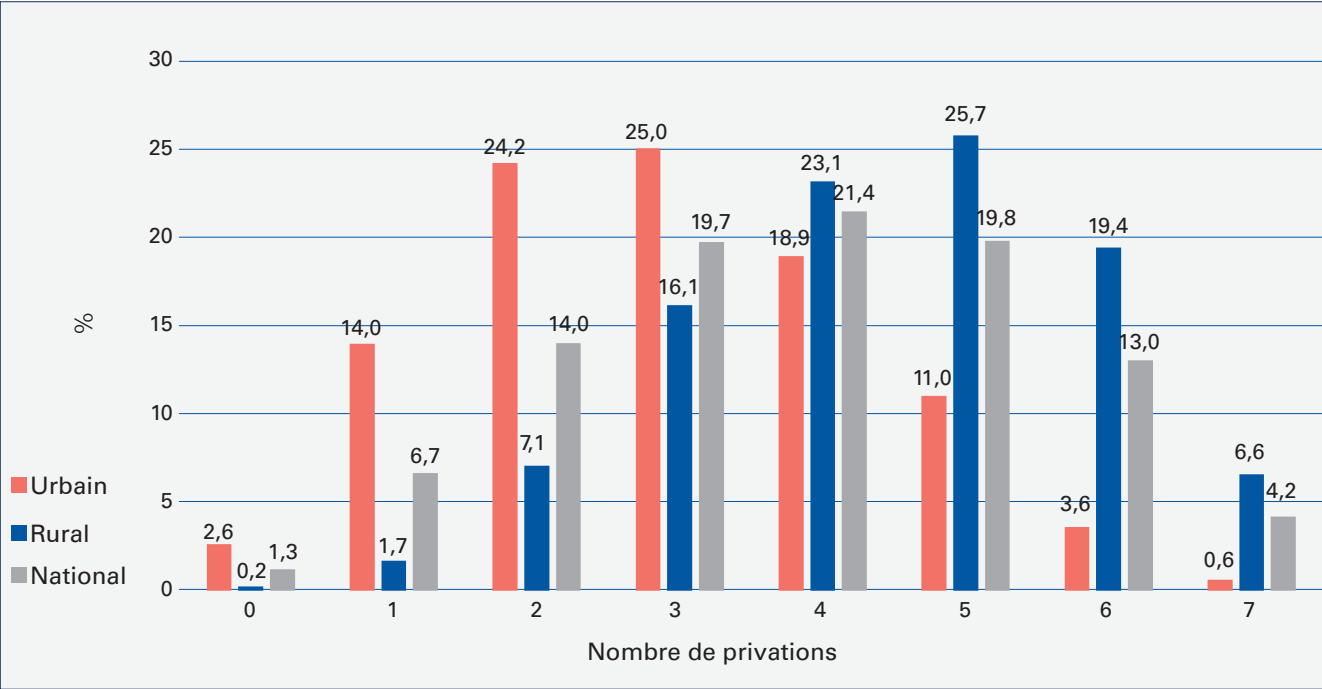
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Note : Différences statistiquement significatives pour un test de χ^2 ($p < 0.05$)

Analyse multidimensionnelle de la privation

L'analyse multidimensionnelle des privations chez les enfants de 5 à 14 ans montre que 21,4% des enfants de ce groupe d'âge sont privés dans 4 des 7 dimensions considérées pour cette analyse. En revanche seul 4,2% sont simultanément privés dans les 7 dimensions et 1,2% dans aucune des dimensions. La distribution des privations par milieu de résidence confirme également que les enfants vivant dans un milieu rural font face à plus de privations simultanées comparé aux enfants du même groupe d'âge mais vivant en milieu urbain. Par exemple, 6,6% des enfants en milieu rural sont privés dans les 7 dimensions contre 0,6% pour les enfants des milieux urbains.

Figure 16. Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés simultanément pour 0 à 7 dimensions au niveau national et selon le milieu de résidence



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

L'indice de privation multidimensionnelle (H) des enfants de 5 à 14 ans au Sénégal (Tableau 13) est de 58,4%. Cela signifie que 58,4% des enfants de ce groupe d'âge subissent une privation simultanée dans au moins 4 des 7 dimensions. Deuxièmement, la privation moyenne subie par les enfants multidimensionnellement pauvres (A) indique que ces enfants sont en moyenne simultanément privés dans 5 des 7 dimensions. Étant donné que l'incidence de la privation est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain, l'indice de privation multidimensionnelle, M0, est plus élevé pour les enfants des zones rurales. En d'autres termes, les enfants âgés entre 5 et 14 ans sont moins bien lotis aussi bien en matière de prévalence de la pauvreté multidimensionnelle que de son intensité. Ceci est également le cas pour les filles en union et les enfants non couverts par une assurance maladie.

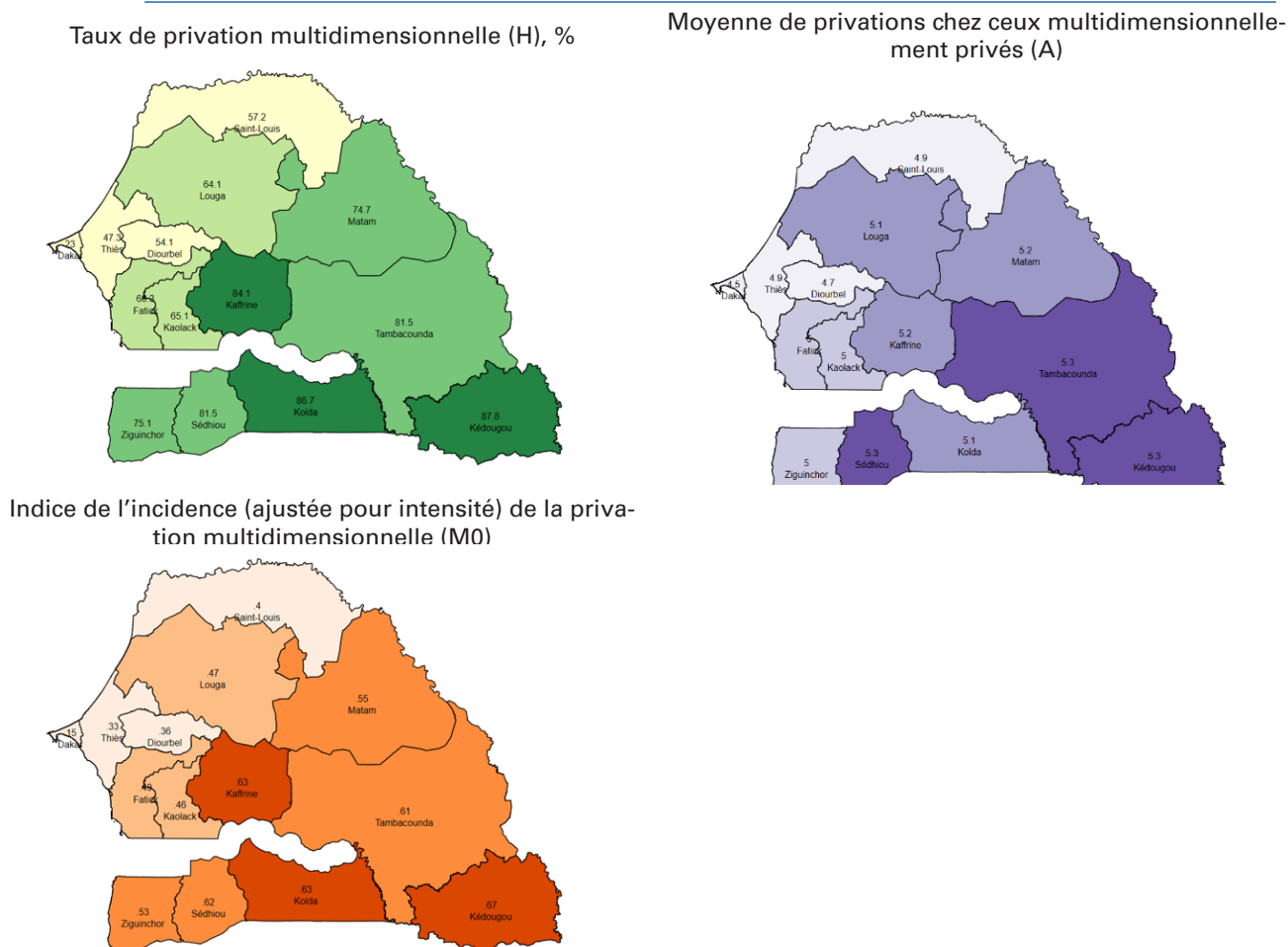
Tableau 13. Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 5-14 ans avec K=4

	Taux de privation multi- mensionnelle (H), %	Moyenne de privations chez ceux multidimensionnelle- ment privés (A)	Indice de l'incidence (ajustée pour intensité) de la privation multidimensionnelle (M0)
National	58,4	5,0	0,4
Urbain	34,2	4,6	0,2
Rural	74,9	5,1	0,5
Mariée (filles)	94,3	5,6	0,8
Non-mariée (filles)	58,3	5,0	0,4
Couverture maladie	11,1	4,6	0,1
Pas de couverture maladie	59,9	5,0	0,4

Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Les indices de privation multidimensionnelle varient aussi entre les régions du Sénégal. Les régions dotées de taux élevés de privation multidimensionnelle sont Kédougou (86,7%), Kolda (86,7%) et Kaffrine (84,1%) alors que Dakar (23%), Thiès (47,3%), Diourbel (54,1%) et Saint-Louis (57,2%) ont des taux plus faibles. C'est en revanche dans les régions du sud est (Tambacounda (5,3) et Kédougou (5,3)), et du Sud (Sédhiou (5,3)) que l'intensité de la privation (A en valeur absolue) est la plus élevée. Comme pour les enfants de moins de 5 ans, les régions dans le sud-est du pays sont les plus défavorisées en termes de pauvretés multidimensionnelles (voir la cartographie de M0).

Figure 17. *Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 5-14 ans avec K=4, par région*



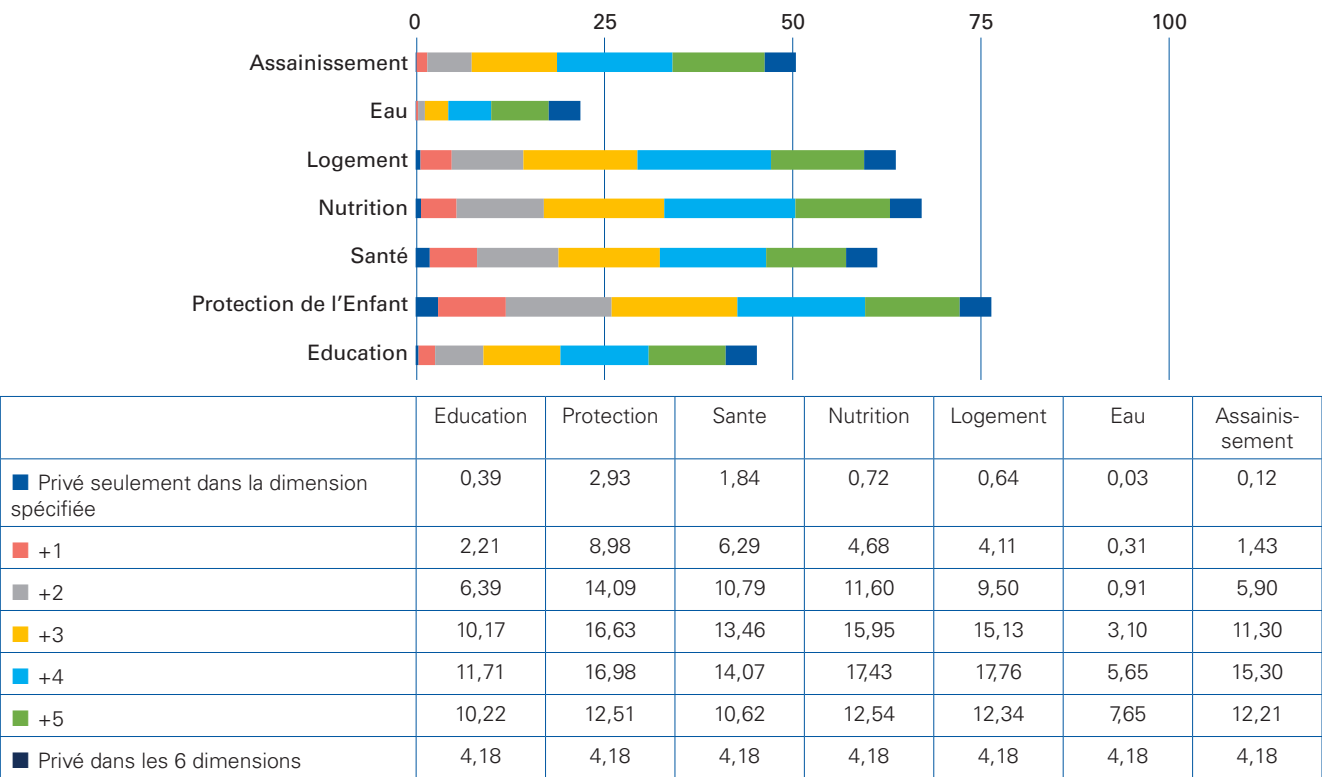
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Analyse du chevauchement de la privation multidimensionnelle

Chevauchement par dimension

L'analyse du chevauchement des privations reconfirme qu'un très faible pourcentage d'enfants est privé dans une seule dimension, quelle que soit la dimension (voir la figure suivante). Quel que soit la dimension considérée, une part plus élevée des enfants du groupe d'âge 5-14 ans a tendance à être privée dans la dimension spécifiée et dans 4 autres dimensions simultanément (figure 18). Seule la dimension de l'eau présente un nombre plus élevé de privations moyennes parmi les enfants privés dans cette dimension et 5 autres.

Figure 18. Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés dans une dimension spécifiée et dans 1, 2, 3, 4, 5 autres



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Chevauchement sur trois dimensions

Le diagramme de Venn dans la figure suivante (Fig 19.), fournit les informations sur la privation entre trois dimensions. Pour la combinaison des dimensions assainissement, eau et éducation il est possible d'observer (1) les taux de privation pour chaque dimension: 17,4% des enfants sont privés dans la dimension assainissement uniquement, 2,3% dans l'eau uniquement, et 16,7% pour l'éducation uniquement; (2) le chevauchement de privations entre deux dimensions : par exemple, la privation chevauchée entre l'eau et l'assainissement est de 16,9% (total de 7,2% et de 9,7%) ; (3) le chevauchement de privations entre toutes les dimensions : 9,7% ; et (4) la proportion d'enfants qui ne sont privés dans aucune des dimensions montrées dans ce diagramme : 27,9% des enfants âgés de 5 à 14 ans. Le même type d'analyse peut être réalisé pour toutes les autres combinaisons ; trois autres chevauchements sont analysés pour ce groupe d'âge.

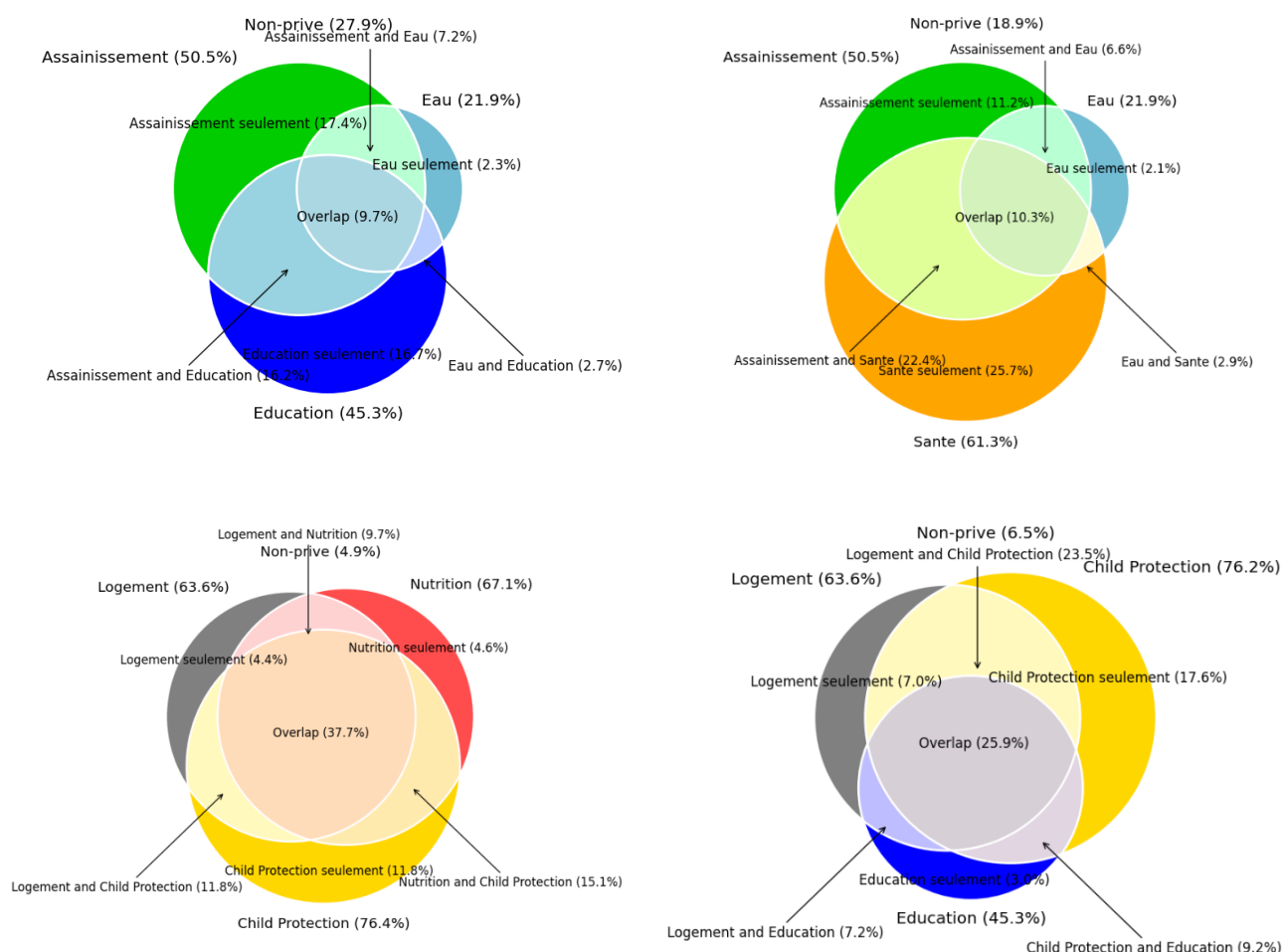
Pour la combinaison des dimensions assainissement, eau et santé, un chevauchement des privations dans les trois dimensions de l'ordre de 10,3% est observé. En général, la privation dans la dimension eau (21,9%) est moins importante que dans les dimensions assainissement (50,5%) et santé (61,3%). Le chevauchement des privations dans ces deux dernières dimensions est de l'ordre de 32,7% (total de 22,4% et 10,3%) alors que le chevauchement entre les privations dans l'assainissement et l'eau et l'eau et la santé concerne un pourcentage moins important d'enfants, 16,9% et 13,2% respectivement. Comme pour la combinaison précédente, les enfants privés dans la dimension eau ont tendance à l'être dans au moins une des autres dimensions.

Pour ce qui est des privations conjointe le diagramme montre que 37,7% des enfants de 5-14 ans sont privés dans les dimensions du logement, de la nutrition et de la protection. De manière générale, une partie importante des enfants

de 5 à 14 ans est privée dans au moins une de ces dimensions. En effet, seuls 4,9% des enfants du groupe d'âge 5-14 ans ne sont privés dans aucune des dimensions considérées. De plus, les taux de privations pour ces trois dimensions prises séparément dépassent les 60%. Finalement, une faible partie des enfants de ce groupe d'âge est concernée par une privation unique pour une de ces dimensions : 4,4% privés dans le logement uniquement, 4,6% dans la nutrition uniquement et 11,8% dans la protection de l'enfant uniquement.

Finalement, pour ce qui est de la combinaison logement, protection de l'enfant et éducation, 25,9% des enfants âgés de 5 à 14 ans sont privés pour les trois dimensions à la fois. La privation globale pour la dimension éducation (45,3%) est plus basse que les privations observées pour le logement (63,6%) et la protection (76,2%). Les enfants privés dans la dimension éducation ont tendance à l'être pour au moins une des deux autres à la fois ; seuls 3% des enfants de ce groupe d'âge sont privés seulement dans la dimension éducation.

Figure 19. Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans privés simultanément pour quatre combinaisons de trois dimensions



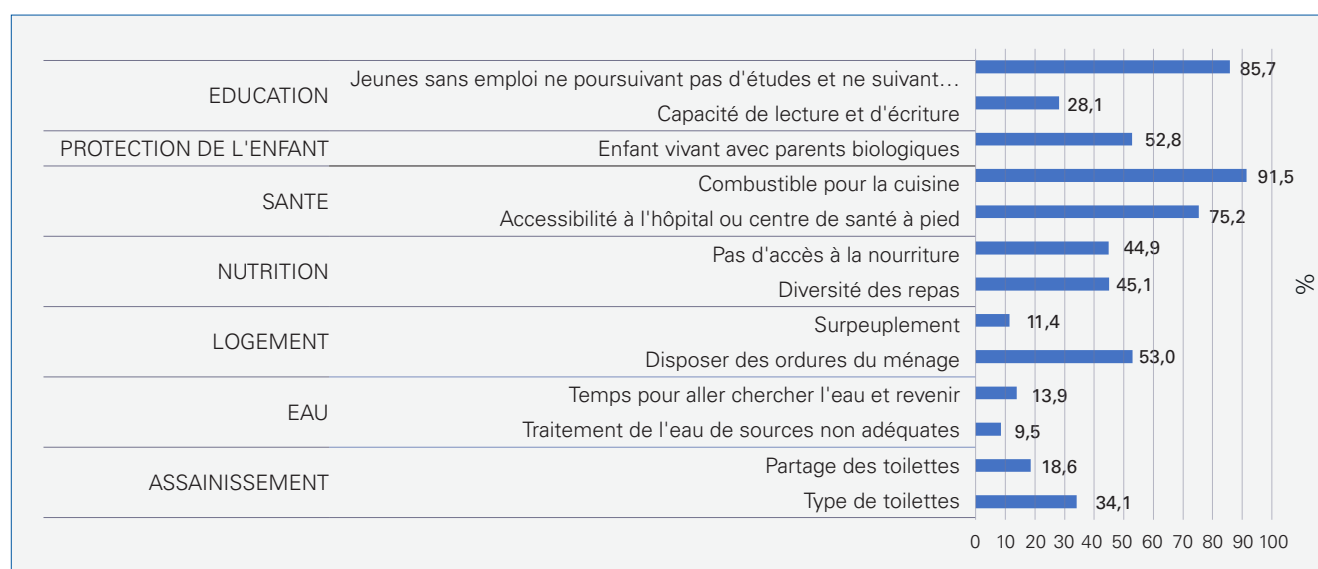
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Enfants âgés de 15-17 ans

Analyse unidimensionnelle de la privation

Pour les enfants de 15 à 17 ans, la privation la plus importante est observée pour l'indicateur de combustible utilisé pour la cuisine dans la dimension santé (91,5%). Ensuite, 85,7% des enfants de ce groupe d'âge est sans emploi ou ne poursuit pas d'études ni de formation (NEET)³⁷. Le troisième taux le plus élevé est pour le deuxième indicateur de la dimension santé, l'accessibilité à pied aux structures de santé (75,2%). Les indicateurs pour lesquels les taux de privations sont les plus bas sont : le traitement de l'eau quand elle provient d'une source inadéquate (8,5%), le surpeuplement (11,4%) et le temps pour aller chercher de l'eau (13,9%).

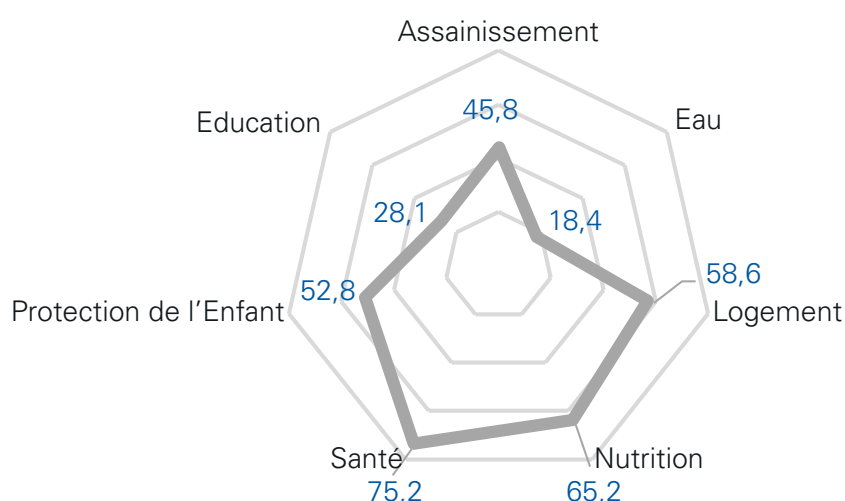
Figure 20. Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés par indicateur et par dimension



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Pour les enfants de 15 à 17 ans, la dimension avec le plus fort taux de privation est celle de la santé (75,2%), suivi du logement (58,6%), après avoir écarté l'indicateur du combustible pour la cuisine, et de la nutrition (65,2%). Le taux de privation le plus bas est observé pour la dimension de l'eau (18,4%) suivi de l'éducation (28,1%).

Figure 21. Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés par dimension au niveau national et milieu de résidence



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

³⁷ Les indicateurs « combustible pour la cuisine » et « NEET » n'ont pas été retenus pour l'analyse par dimension et multidimensionnelle pour cause de variance insuffisante mais ceux-ci restent inclus dans l'analyse unidimensionnelle pour leur pertinence programmatique.

Comme pour les autres tranches d'âges analysés précédemment, les taux de privation les plus élevés sont souvent observés chez les enfants vivant en milieu rural. Toutefois, pour la dimension protection de l'enfant, ce sont les enfants vivant en zone urbaine (57,8%) qui sont les plus privés en comparaison à ceux vivant en zones rurales (47,9%). Outre la zone de résidence, des différences peuvent être observées pour d'autres caractéristiques. Le tableau 14 montre que les enfants les plus défavorisés vivent en milieu rural, sont des filles mariées ou en union, ne sont pas couverts par une assurance maladie, ont un chef de ménage de sexe masculin ou pas diplômé, ou encore, vivent dans un ménage sans éclairage adéquat ou dans un logement constitué de matériaux inadéquats. Cependant, pour les dimensions santé et protection de l'enfant, les différences sont faibles et montre parfois même la tendance inverse.

Tableau 14. *Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés par dimension selon certaines caractéristiques*

	Profil	As-sainissement	Eau	Logement	Nutrition	Santé	Protection de l'Enfant	Éducation
National	National	45,84	18,39	58,61	65,17	75,22	52,78	28,14
Milieu de résidence	Urbain	31,77	7,76	35,03	55,94	72,98	57,79	17,47
	Rural	59,52	28,73	81,54	74,15	77,60	47,91	38,52
Mariage des enfants (filles)	Mariée	69,18	37,61	74,08	72,81	86,69	83,95	64,05
	Non-mariée	44,10	16,95	57,45	64,60	74,35	50,45	25,45
Couverture maladie	Couvert	17,0	5,1	18,7	27,9	88,4	44,4	4,2
	Non couvert	46,4	18,6	59,4	65,9	75,0	52,9	28,6
Sexe chef du ménage	Masculin	49,64	21,77	64,17	66,80	76,08	39,19	30,82
	Féminin	34,47	8,26	41,96	60,29	72,85	93,52	20,14
Diplôme plus élevé du chef de ménage (3 catégories)	Études moyennes ou plus	25,36	5,67	27,91	42,55	76,01	56,64	6,65
	CEP/CFEE	33,69	12,19	44,62	54,54	70,41	59,87	13,03
	Aucun	49,40	20,47	63,54	68,84	75,60	51,65	32,11
Source d'éclairage adéquate	Oui	35,51	10,63	49,13	57,99	73,76	55,85	22,54
	Non	76,79	41,61	87,00	86,67	80,28	43,59	44,91
Matériaux adéquats pour les murs, toit et sols	Non	60,44	27,77	74,85	74,91	78,84	49,39	35,22
	Oui	24,04	4,38	34,36	50,63	70,26	57,85	17,57

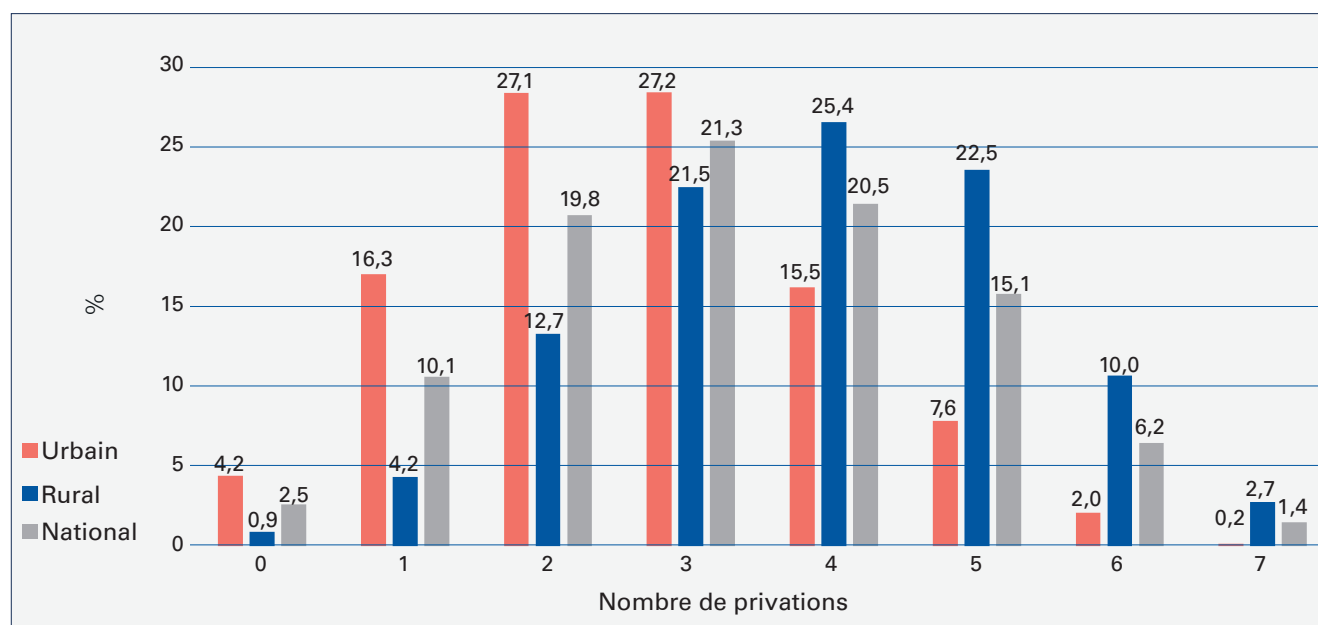
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Note : Différences statistiquement significatives pour un test de χ^2 ($p < 0.05$)

Analyse multidimensionnelle de la privation

L'analyse multidimensionnelle chez les enfants âgés de 15 à 17 ans montre que 24,3% des enfants de ce groupe d'âge est privé dans 3 des 7 dimensions considérées pour cette analyse. Au niveau national, 2,5% des enfants ne sont privés dans aucune des dimensions et 1,4% des enfants subissent des privations dans les 7 dimensions. Les différences entre les milieux de résidences sont plus importantes pour la privation de 5 des 7 dimensions. A titre d'illustration, en zone rurale, 22,5% des enfants sont privés contre seulement 7,5% des enfants en zone urbaine soit une différence de 200% (15 pp). De manière générale, la distribution des privations chez les enfants des zones urbaines tend plus vers la gauche en comparaison de la situation nationale et de celle observée en milieu rural. Les enfants vivant en zones urbaines ont tendance à être privés dans moins de dimensions.

Figure 22. *Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés simultanément pour 0 à 7 dimensions au niveau national et selon le milieu de résidence*



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Trois indices de privation multidimensionnelle sont présentés dans le tableau 15. Il s'agit de l'indice de privation multidimensionnelle (H), la moyenne des privations subi par les enfants multidimensionnellement pauvres (A) et l'indice de privation multidimensionnelle ajustée pour l'intensité (M0), pour un seuil de 4 des 7 dimensions considérées pour l'analyse. L'indice de privation multidimensionnelle pour les enfants de 15 à 17 ans est de 43,2% au niveau national, 7% pour les enfants couverts par une assurance maladie et 43,9% pour les non-couverts. La moyenne des privations (A) est de 4,7 au niveau national ; 5,2 pour les enfants couverts par une assurance maladie contre 4,7 pour les enfants non-couverts. Le M0 indiquent les caractéristiques qui sont associées à une privation multidimensionnelle plus importante, aussi bien en matière d'incidence que d'intensité. Les caractéristiques des enfants les plus privés multidimensionnellement correspondent à ceux privés pour chaque dimension comme l'a montré l'analyse unidimensionnelle.

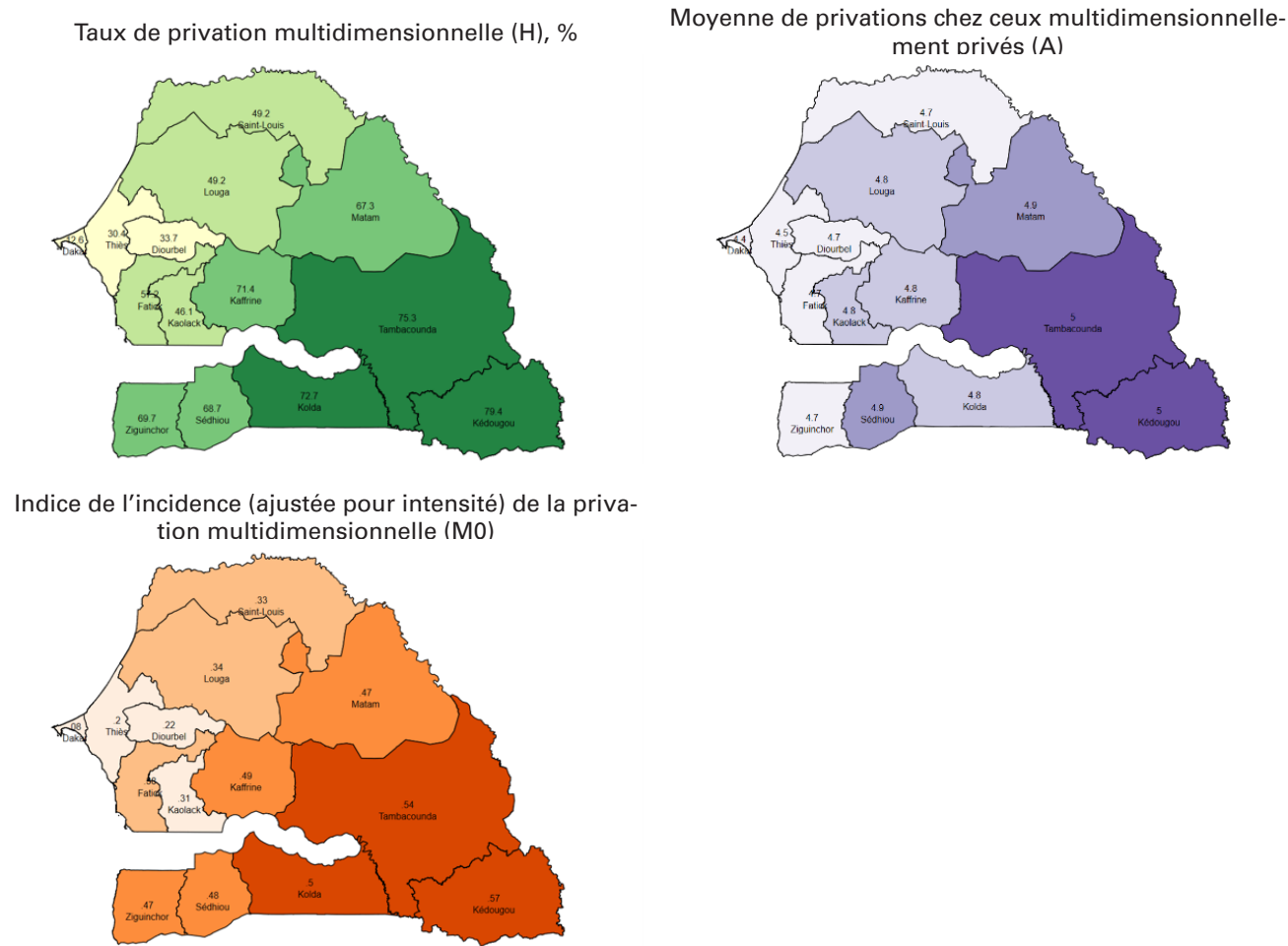
Tableau 15. *Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 15-17 ans avec K=4*

	Taux de privation multidimensionnelle (H), %	Moyenne de privations chez ceux multidimensionnellement privés (A)	Indice de l'incidence (ajustée pour intensité) de la privation multidimensionnelle (M0)
National	43,2	4,7	0,29
Urbain	25,2	4,5	0,16
Rural	60,8	4,8	0,42
Mariée (filles)	76,1	5,4	0,58
Non-mariée (filles)	40,8	4,6	0,27
Couverture maladie	7,0	5,2	0,05
Pas de couverture maladie	43,9	4,7	0,30

Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Les taux de privation multidimensionnelle sont toujours plus élevés dans le sud-est du pays, comme cela a été observé pour les autres tranches d'âges. Les taux sont plus élevés pour Kédougou (79,4%), Tambacounda (75,3%) et Kolda (72,7%) et plus bas pour Dakar (12,6%), Thiès (30,4%) et Diourbel (33,7%).

Figure 23. Indices de privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 15-17 ans avec K=4, par région



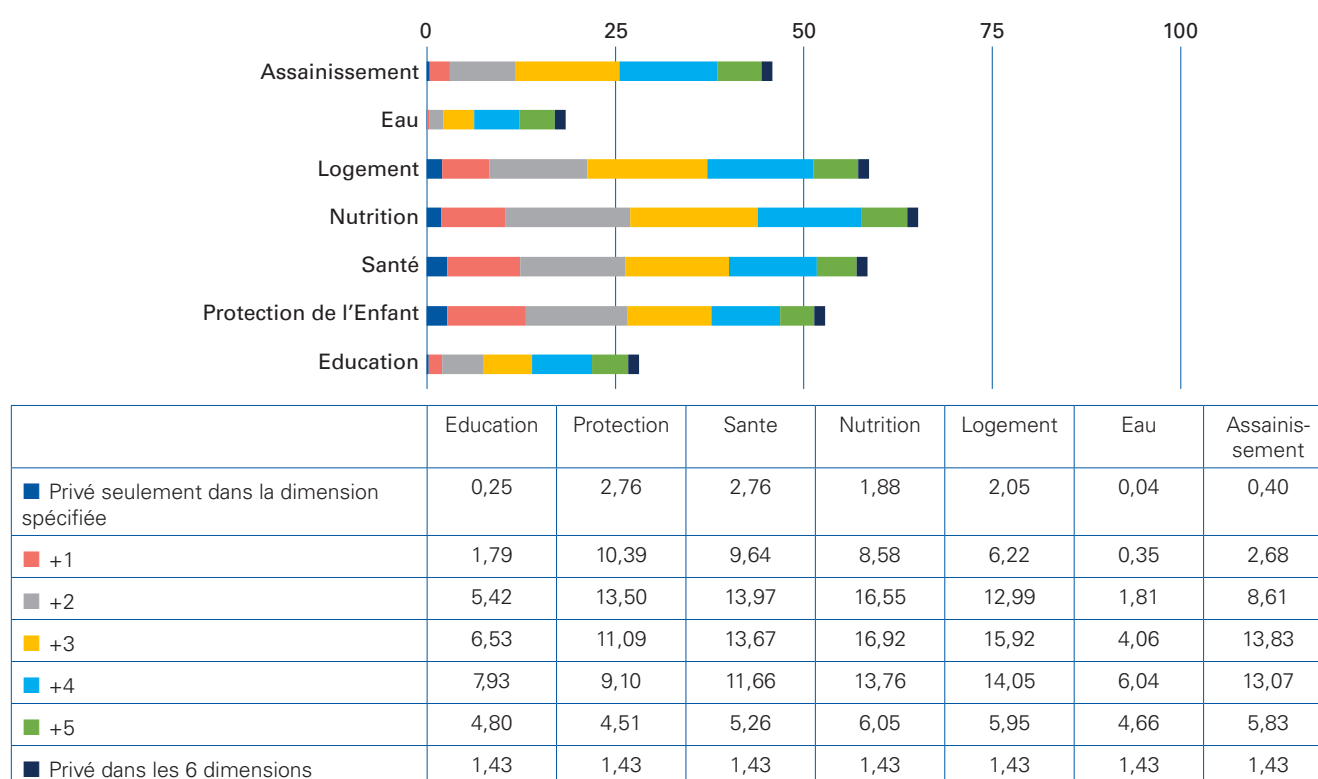
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Analyse du chevauchement de la privation multidimensionnelle

Chevauchement par dimension

La nutrition est la dimension avec le plus fort taux de privation (65,2%). Toutefois, seul 1,9% des enfants de 15 à 17 ans subissent la privation dans cette dimension uniquement. En effet, la majorité des enfants privés dans la dimension nutrition sont également privés dans une (8,6%), deux (16,6%), trois (17%), quatre (13,8%), cinq (6,1%) ou six (1,4%) dimensions additionnelles. Ceci est le cas également pour la dimension protection de l'enfant, santé, et logement. Finalement, 1,4% des enfants sont privés dans les 7 dimensions en même temps.

Figure 24. Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés dans une dimension spécifiée et dans 1, 2, 3, 4, 5 autres



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Chevauchement sur trois dimensions

Le diagramme de Venn de la figure 25, fournit les informations à propos de la privation dans quatre combinaisons de trois dimensions.

Pour la combinaison des dimensions assainissement, eau et nutrition il est possible d'observer (1) les taux de privation pour chaque dimension : 8,2% des enfants sont privés dans la dimension assainissement uniquement, 0,9% dans l'eau uniquement, et 25,9% dans la nutrition uniquement; (2) le chevauchement de privations entre deux dimensions: par exemple, la privation chevauchée entre l'eau et l'assainissement est de 13,9%; (3) le chevauchement de privations entre toutes les dimensions : 12%; et (4) la proportion d'enfants qui ne sont privés dans aucune des dimensions : 23,8% des enfants âgés de 15 à 17 ans. Le même type d'analyse peut être réalisé pour toutes les autres combinaisons ; trois autres exemples sont montrés pour ce groupe d'âge.

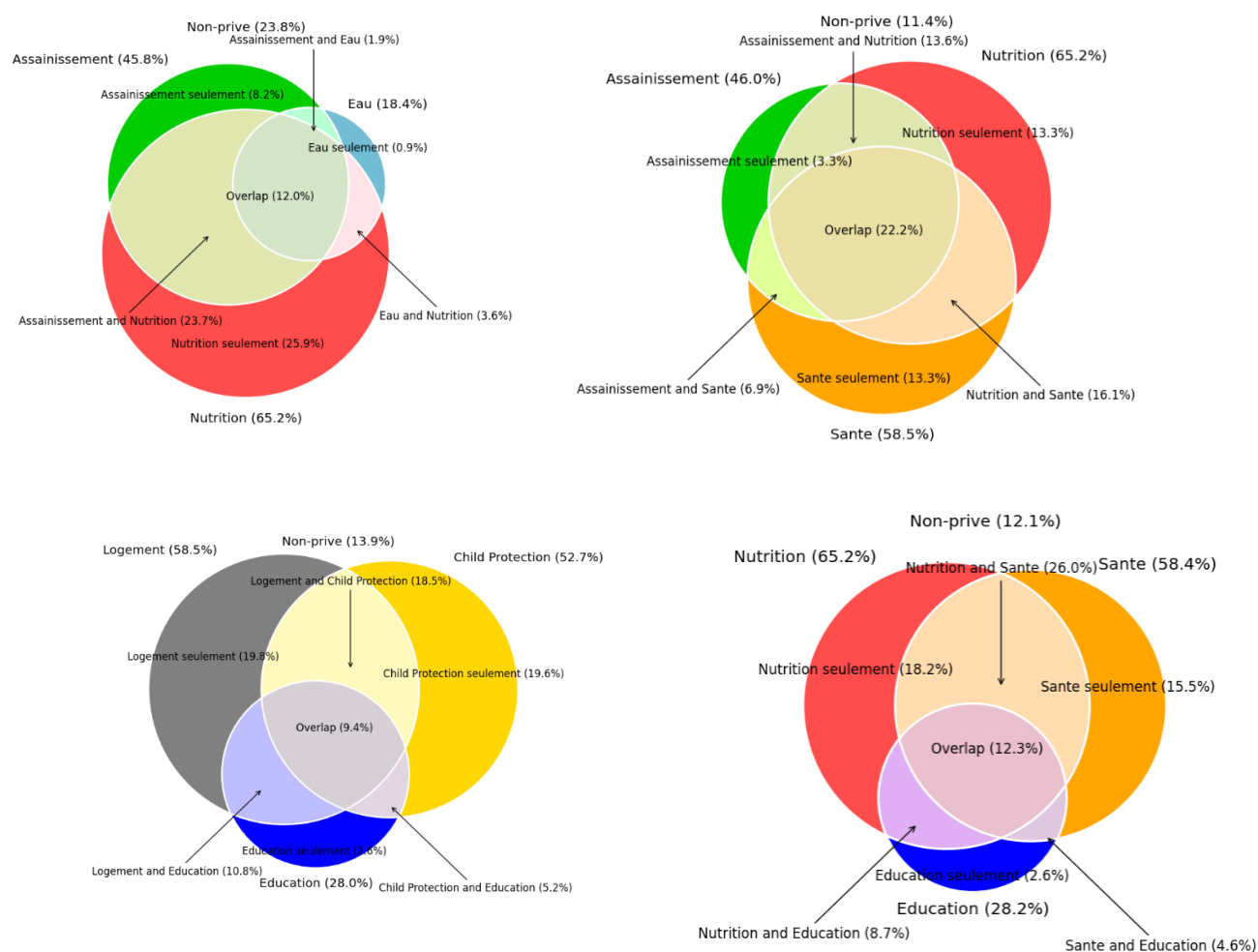
Pour la combinaison des dimensions assainissement, nutrition et santé, 22,2% des enfants sont privés simultanément. De manière générale, le taux de privation pour la dimension assainissement (46%) est inférieur à ceux observés pour les dimensions nutrition (65,2%) et santé (58,5%). En effet, 3,3% des enfants de ce groupe d'âge sont privés pour la dimension assainissement uniquement, ce qui représente 7,2% de tous ceux privés pour cette dimension. En revanche, 20,4% des enfants sont privés dans la dimension « nutrition » uniquement contre 22,7% privés dans la dimension « santé ».

Le niveau de chevauchement observé entre les dimensions logements, protection de l'enfant et éducation est estimé à 9,4%. La forme du diagramme de Venn confirme cette observation. En effet, 19,8%, 19,6% et 2,6% des enfants sont

privés uniquement pour les dimensions logement, protection de l'enfant et éducation, respectivement. Le niveau de privation observé pour la dimension éducation est faible par rapport aux privations pour les deux autres dimensions. Une part plus importante de ceux privés pour l'éducation (90,7%) le sont pour au moins une des deux autres dimensions. En revanche, seuls 62,8% et 66,2% des enfants privés dans les dimensions de la protection de l'enfant et du logement sont dans la même situation.

Le même format de chevauchement est observé pour la combinaison nutrition, santé et éducation avec 12,3% des enfants âgés de 15 à 17 ans privés dans ces trois dimensions simultanément.

Figure 25. Pourcentage d'enfants âgés de 15-17 ans privés simultanément pour quatre combinaisons de trois dimensions



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19



5. Conclusions et recommandations

Les principaux résultats de l'étude de la pauvreté portant sur la population totale d'enfants au Sénégal ont permis de montrer que 43,3 % des enfants sénégalais âgés de 0 à 17 ans vivent dans des ménages pauvres. Ils sont 50,7 % en situation de pauvreté multidimensionnelle dans au moins quatre des sept dimensions analysées. La prise en compte de la privation subjective a permis de révéler que 52 % des ménages se considèrent comme pauvres au Sénégal.

L'analyse de la pauvreté multidimensionnelle a révélé que le taux de privation est plus élevé chez les enfants de 5 à 14 ans (58 %), suivis par les enfants de 15 à 17 ans (43,2 %), et les enfants de moins de 5 ans (39,7 %). Cependant, quel que soit l'âge, les enfants vivant en milieu rural ou dans les régions sud du pays, en particulier Sédhiou et Kolda, sont plus souvent confrontés à des privations. En outre, peu d'enfants semblent subir des privations dans une seule dimension. En moyenne, les enfants multidimensionnellement pauvres souffrent de privations dans 4,6, 5 et 4,7 dimensions respectivement chez les moins de 5 ans, les 5-15 ans et les 15-18 ans. Par exemple, 37,7 % des enfants âgés de 5 à 14 ans subissent des privations dans les dimensions logement, nutrition et protection de l'enfant en même temps. Pour ce même groupe d'âge, 25,9 % des enfants souffrent de privations dans les dimensions logement, nutrition et éducation. Chez les enfants de moins de 5 ans, 27,3 % connaissent des privations dans l'assainissement, la santé et le logement simultanément. Enfin, 22 % des enfants âgés de 15 à 17 ans subissent des privations simultanées dans les dimensions assainissement, nutrition et santé.

Les résultats des analyses réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de dégager les recommandations suivantes afin d'améliorer les mesures de lutte contre la pauvreté de l'enfant au Sénégal et de favoriser le bien-être des enfants d'une manière générale.

- o Les régions du sud-est affichent des taux de privation plus élevés que celles de l'ouest, en particulier Dakar, où la pauvreté est moindre.
- o L'accès à l'électricité et l'utilisation de matériaux de construction rudimentaires sont associés à une prévalence plus importante de la pauvreté. Ces données sont facilement observables chez les ménages.
- o En zone rurale, on constate qu'une grande partie des enfants pauvres subjectivement le sont aussi monétairement et multidimensionnellement. Dans ce contexte, l'adoption d'une approche communautaire peut être pertinente pour identifier les enfants en situation de pauvreté.

Recommandations pour réduire la pauvreté et favoriser le bien-être des enfants du Sénégal

1

Établir un plan d'intervention à plusieurs niveaux afin de réduire la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant :

- o Identifier les dimensions contribuant le plus fortement à la pauvreté multidimensionnelle en utilisant les résultats de l'analyse MODA.
- o Identifier les liens (de cause à effet) entre ces dimensions et les autres en étudiant de près les résultats des analyses de chevauchement.
- o Plaider en faveur de la mise en place de programmes multisectoriels (pour les secteurs clés définis préalablement).
 - Pour les enfants de 0 à 4 ans : le chevauchement de privations le plus important est observé entre les dimensions assainissement, logement et santé (27 %).
 - Pour les enfants de 5 à 14 ans : le chevauchement de privations le plus important est observé entre les dimensions protection de l'enfant, logement et nutrition (38 %).
 - Pour les enfants de 15 à 17 ans : le chevauchement de privations le plus important est observé entre les dimensions assainissement, logement et nutrition (28 %)
- o Suivre les résultats de ces programmes en utilisant les indicateurs retenus pour le MODA comme indicateur de performance.

2

Identifier les groupes prioritaires dans le cadre d'un plan de protection sociale national à moyen et à long terme. Lorsque les ressources sont limitées, le ciblage est souvent privilégié afin d'affecter les ressources aux populations identifiées comme étant les plus vulnérables. Si le ciblage peut servir d'outil à court terme, l'adoption d'une approche universelle au niveau national s'avère plus pertinente pour démontrer les résultats positifs d'un programme à long terme. Moins coûteuse dès lors que l'on adopte une vision économique plutôt que comptable, cette approche tient également compte des coûts sociaux associés à la non-intervention auprès de certains groupes. Les profils suivants sont ressortis comme étant le plus souvent associés à la pauvreté, indépendamment du type de pauvreté considéré:

- o Les régions du sud-est en comparaison à celles de l'ouest et en particulier Dakar où la pauvreté est moindre
- o L'accès à l'électricité et l'utilisation de matériaux de construction rudimentaires sont associés à une prévalence plus importante de la pauvreté. Ces données sont facilement observables chez les ménages.
- o En zone rurale, on constate qu'une grande partie des enfants pauvres subjectivement le sont aussi monétairement et multidimensionnellement. Dans ce contexte, l'adoption d'une approche communautaire peut être pertinente pour identifier les enfants en situation de pauvreté.

3

Suivre les tendances en matière de pauvreté de l'enfant grâce à des études régulières. Le renforcement continu des capacités des différents acteurs à tous les niveaux permettra à terme la réalisation de ces études à l'échelle nationale, régionale et départementale. Un plan de formation à court et à moyen terme pourrait prendre la forme suivante:

- o Formation d'acteurs clés aux outils méthodologiques adoptés dans le cadre de cette étude ; en présentiel pour une durée d'une semaine.
- o Réalisation de la prochaine étude par les acteurs précédemment formés avec appui à distance de SPRI ; format coaching tout le long du processus d'analyse jusqu'à la rédaction et la validation du rapport.

Annexe I : Sélection des paramètres pour l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant en utilisant l'EHCVM 2018/19

Tableau 1. *Liste des paramètres (dimensions, indicateurs et groupe d'âge) de l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant*

Dimensions	Indicateurs	Définition	Groupe d'âge		
			0-4 ans	5-14 ans	15-17 ans
Assainissement	Type de sanitaire	Enfant vivant dans un ménage utilisant des toilettes non améliorées : Latrines SANPLAT; Latrines dallées simples; Fosse rudimentaire; Toilettes publiques; Aucune toilette; Autre	x	x	x
	Partage des toilettes	Enfant vivant dans un ménage partageant les toilettes avec d'autres ménages	x	x	x
Eau	Source d'eau pour boire	Enfant vivant dans un ménage utilisant une source d'eau non adéquate en saison des pluies et ne la traitant pas de manière adéquate: - 5 Puits ouvert dans la cour/Concession; - 6 Puits ouvert ailleurs; - 12 Source non aménagée; - 13 Fleuve/Rivière/Lac/Barrage; - 16 Vendeur ambulante; - 17 Autre (à préciser) OU en saison sèche: - 5 Puits ouvert dans la cour/Concession; - 6 Puits ouvert ailleurs; - 12 Source non aménagée; - 13 Fleuve/Rivière/Lac/Barrage; - 16 Vendeur ambulante; - 17 Autre (à préciser) Traitement non adéquat de l'eau: filtrer à travers linge; laisser reposer ; autre	x	x	x
	Temps pour aller chercher l'eau	Enfant vivant dans un ménage ou le temps pour aller chercher l'eau excède 30mins en saison des pluies OU en saison sèche	x	x	x
Logement	Débarras des ordures ménagères	Enfant vivant dans un ménage utilisant un mode inadéquat de débarras des ordures ménagères: 3 brûlées ; 5 dépotoir sauvage; 6 autre	x	x	x
	Surpeuplement	Enfant vivant dans un ménage ou dorment plus de 3 personnes par pièces	x	x	x
Nutrition	Diversité des repas	Enfant vivant dans un ménage n'ayant pas consommé d'aliments des 4 groupes alimentaires (carbohydrates, protéines, fruits/légumes, graisses) une fois par jour sur la dernière semaine		x	x
	Sécurité alimentaire/ Non-accès à la nourriture pour se nourrir à sa faim	Enfant vivant dans un ménage qui n'avait plus de nourriture, OU - avec un des membres ayant - dû sauter un repas, - mangé moins que ce qu'il pensait nécessaire, - eu faim mais sans avoir mangé - passé toute une journée sans manger - au moins une fois durant les 12 derniers mois par manque d'argent ou d'autres ressources	x	x	x

Dimensions	Indicateurs	Définition	Groupe d'âge		
			0-4 ans	5-14 ans	15-17 ans
Santé	Type de combustibles utilisés pour cuisiner	Enfant vivant dans un ménage ou utilisant du combustible solide pour cuisiner : bois ra-massé, bois acheté, charbon de bois, déchets animaux, autres	x	x	x
	Accès à une structure de santé : l'hôpital ou autre centre de santé	Enfant vivant dans une localité d'où il/elle ne peut accéder à pied à une structure de santé	x	x	x
Protection de l'enfant	Disponibilité de l'acte de naissance	Enfant n'ayant pas d'acte de naissance	x	x	
	Travail des enfants (économique et domestique)	Enfant effectuant travail économique ou domestique pendant au moins 1h		x	
	Enfant vivant avec ses deux parents	Enfant ne vivant pas avec ses deux parents biologiques	x	x	x
Éducation	Capacité de lecture et d'écriture	Enfant en capacité de lire et d'écrire			x
	Fréquentation scolaire	Enfant n'étant pas à l'école		x	
	Jeunes sans emploi ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation (NEET)	Enfant sans emploi ne poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation (NEET)			x

Tableau 2. Liste des participants aux ateliers de sélection des paramètres pour l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant

Jour 1 UNICEF Sénégal CO

Silvia Danailov	Lalaina Fatratra Andriamasinoro
Georges Gonzales	Alpha Seydi Ndiaye
Amel Cheikhrouhou	Omar Habib
Ui Don Chung	Mame Thierno Lo
Arnaud Houndeganme	Mouhamadou Fall
Boubacar Ndaw	

Jour 2 Hotel Le Ndiambour

Samba Ndiaye	Ndatar Sene
El hadji Cheikh Gueye	Marie Th. Pierre Ndiaye
Khaly Gueye	Oumar Ndiaye
Ndeye Fatou Niang	Ousmane Basse
Keyndou Acrachi	Awa Wade Sow
Racine Kane	Mouhamadou Fall
Atoumane Fall	Elhadji Yaya Ly
Aminata Drame	Ndeye Bineta Dieme
Assiétou Fall	

Annexe II : Formules pour le calcul des taux de privation et des indices de privation multidimensionnelle

L'incidence de la privation pour chacun des indicateurs ou chacune des dimensions est calculé en utilisant la formule suivante.

Taux de privation par dimension ou indicateur

$$h_{j,r} = \frac{q_{j,r}}{n_r}$$

Avec

$$q_{j,r} = \sum_{i=1}^{n_r} y_j$$

$h_{j,r}$ Taux d'incidence des enfants subissant des privations dans la dimension ou l'indicateur j de la population de référence r

q_j Le nombre d'enfants de la population de référence r subissant des privations dans la dimension ou l'indicateur j

n_r Le nombre total des enfants de la population de référence r

y_j Niveau de privation de l'enfant i dans la dimension ou l'indicateur j avec $y_j=1$ si $x_j < Z_j$ (privation) et $y_j=0$ si $x_j \geq Z_j$ (pas de privation)

x_j Importance de la dimension ou de l'indicateur j pour l'enfant i

z_j Seuil de la dimension j

En revanche, les formules suivantes permettent de compter le nombre de privations pour chaque enfant avant de résumer ces informations cruciales pour l'analyse de la privation multidimensionnelle en utilisant trois indices H, A et M0 pour plusieurs seuils k de privation.

Compte des privations par enfant

$$D_i = \sum_{j=1}^d y_j$$

D_i nombre total de dimensions dans lesquelles chaque enfant i subit des privations

y_j $y_j=1$ si subit des privations dans la dimension j et $y_j=0$ si l'enfant ne subit pas de privation dans la dimension j

Taux de privation multidimensionnelle

$$H = \frac{q_k}{n_a}$$

Avec

$$q_k = \sum_{i=1}^n y_k$$

$h_{j,r}$ Taux d'incidence de la privation multidimensionnelle des enfants selon la valeur seuil K dans le groupe d'âge a

q_k Le nombre d'enfants victimes d'au moins K privations dans le groupe d'âge a

n_a Le nombre total des enfants dans le groupe d'âge a

y_k Niveau de privation de l'enfant i en fonction de la valeur seuil K

D_i Importance de la dimension j pour l'enfant i

K Valeur Seuil

Intensité moyenne de la privation multidimensionnelle

$$A = \frac{\sum_1^{q_k} c_k}{q_k \times d}$$

A intensité moyenne de la privation multidimensionnelle selon la valeur seuil K pour le groupe d'âge a;

q_k Le nombre d'enfants victimes d'au moins K privations dans le groupe d'âge a

d nombre total de dimensions considérées par enfant dans le groupe d'âge concerné a;

c_k nombre de privation subies de façon multidimensionnelle par chaque enfant i avec $c_k = D_i \cdot y_k$

Taux de privation multidimensionnelle ajusté pour l'intensité

$$M_0 = H \times A = \frac{\sum_1^{q_k} c_k}{n_a \times d}$$

M_0 taux d'incidence ajusté de la privation multidimensionnelle des enfants chez les enfants subissant au moins K privations dans le groupe d'âge a

q_k Le nombre d'enfants victimes d'au moins K privations dans le groupe d'âge a

d nombre total de dimensions considérées par enfant dans le groupe d'âge concerné a;

c_k nombre de privation subies de façon multidimensionnelle par chaque enfant i avec $c_k = D_i \cdot y_k$

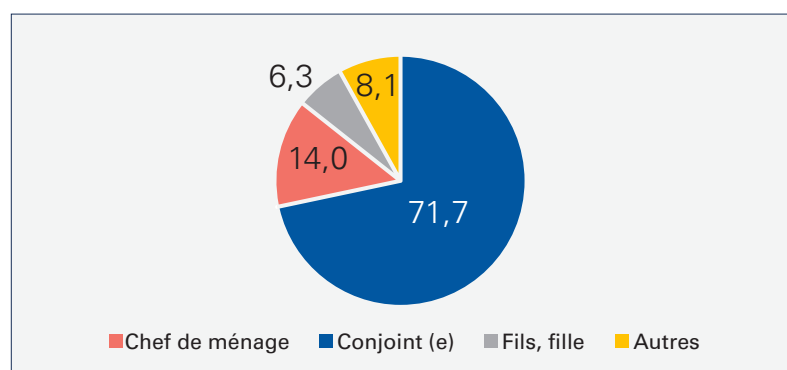
n_a Le nombre total des enfants dans le groupe d'âge a

Annexe III : Module de l'EHCVM sur la pauvreté subjective (sec-tion 20)

(20.01) Pensez-vous que le SENEGAL est un pays pauvre? 1. Oui ☐ 2. Non ☐ 3. Ne sait pas ☐	(20.08) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que le ménage a rencontré des difficultés à faire face aux dépenses pour l'éclairage de la maison (électricité, pétrole lampant, piles pour les lampes, etc.) ? 1. Oui ☐ 3. Ne sait pas ☐ 2. Non ☐ 4. Non concerné ☐												
(20.02) Etant donné le revenu de votre ménage, vous estimez que vous vivez? 1. Bien ☐ 4. Difficilement ☐ 2. Assez bien ☐ 5. Ne sait pas ☐ 3. Passablement ☐	(20.09) Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un membre du ménage a eu un épisode de maladie et a rencontré des difficultés à faire face aux dépenses y afférentes ? 1. Oui ☐ 3. Ne sait pas ☐ 2. Non ☐ 4. Non concerné ☐												
(20.03) Comment vivez-vous par rapport à vos voisins dans la localité? 1. Nettement mieux ☐ 2. Un peu mieux ☐ 4. Moins bien ☐ 3. Pareillement ☐ 5. Ne sait pas ☐	(20.10) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que le ménage a rencontré des difficultés à faire face aux dépenses de transport ? 1. Oui ☐ 3. Ne sait pas ☐ 2. Non ☐ 4. Non concerné ☐												
(20.04) Comment vivez-vous par rapport aux gens de la Capitale? 1. Nettement mieux ☐ 2. Un peu mieux ☐ 4. Moins bien ☐ 3. Pareillement ☐ 5. Ne sait pas ☐ 6 Non-Concerné ☐	(20.11) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que le ménage a rencontré des difficultés à faire face aux dépenses relatives aux frais de scolarité des enfants ? 1. Oui ☐ 3. Ne sait pas ☐ 2. Non ☐ 4. Non concerné ☐												
(20.05) Si on vous demande de classer votre propre ménage sur une échelle de bien-être allant de pauvre à riche, comment le classeriez-vous 1. Riche ☐ 4. Très pauvre ☐ 2. Moyen ☐ 3. Pauvre ☐ 5. Ne sait pas ☐	(20.12) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que le ménage a rencontré des difficultés à faire face aux dépenses relatives aux livres et fournitures scolaires? 1. Oui ☐ 3. Ne sait pas ☐ 2. Non ☐ 4. Non concerné ☐												
(20.06) Quel est le montant minimum mensuel nécessaire à votre ménage pour avoir un niveau de vie décent (FCFA) ?	(20.13) Quelles sont selon vous, les trois principales causes de la pauvreté des ménages? <table border="0"> <tr> <td>1 Manque d'emplois</td> <td>5 Manque de routes</td> <td>9 Cherté de la vie</td> </tr> <tr> <td>2 Pas d'instruction</td> <td>6 Manque d'eau/de pâturages</td> <td>10 Mévente de produits agricoles</td> </tr> <tr> <td>3 Manque de terres</td> <td>7 Sécheresses fréquentes/Inondations</td> <td>11 Parresse</td> </tr> <tr> <td>4 Manque de troupeaux</td> <td>8 Mauvaise gestion/corruption</td> <td>12 Autre</td> </tr> </table> Cause 1 Cause 2 Cause 3	1 Manque d'emplois	5 Manque de routes	9 Cherté de la vie	2 Pas d'instruction	6 Manque d'eau/de pâturages	10 Mévente de produits agricoles	3 Manque de terres	7 Sécheresses fréquentes/Inondations	11 Parresse	4 Manque de troupeaux	8 Mauvaise gestion/corruption	12 Autre
1 Manque d'emplois	5 Manque de routes	9 Cherté de la vie											
2 Pas d'instruction	6 Manque d'eau/de pâturages	10 Mévente de produits agricoles											
3 Manque de terres	7 Sécheresses fréquentes/Inondations	11 Parresse											
4 Manque de troupeaux	8 Mauvaise gestion/corruption	12 Autre											
(20.07) Au cours des 12 derniers mois, est ce que le ménage a rencontré des difficultés à faire face à son loyer? 1. Oui ☐ 3. Ne sait pas ☐ 2. Non ☐ 4. Non concerné ☐													

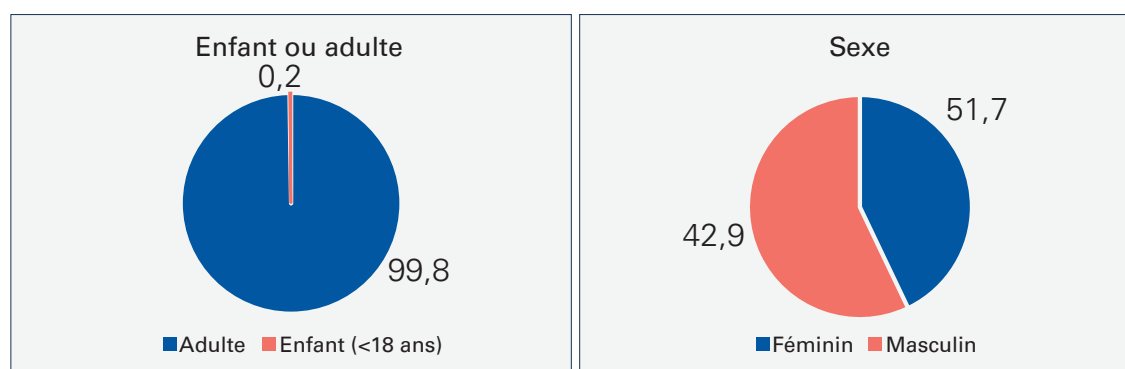
Annexe IV : Caractéristiques du répondant au module de l'EHCVM sur la pauvreté subjective

Figure 1. Part des répondants selon leur lien de parenté avec le chef du ménage, %



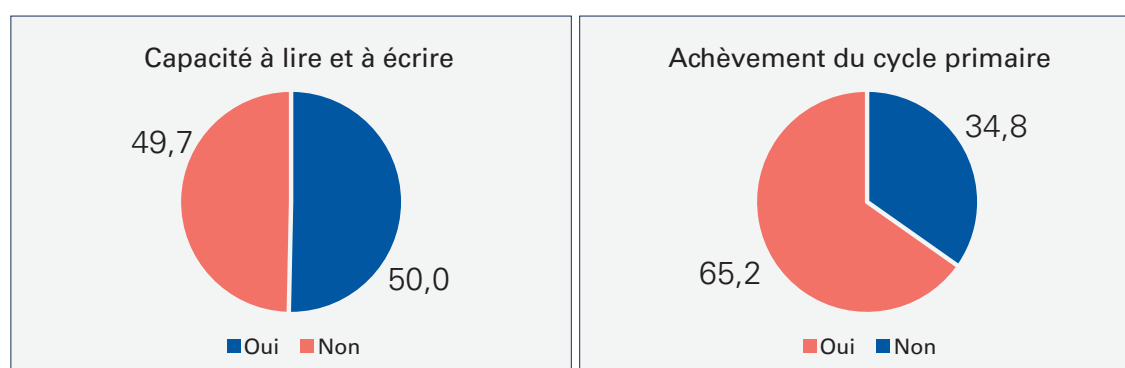
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Figure 2. Par des répondants selon leurs caractéristiques démographiques, %



Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19

Figure 3. Part des répondants selon leur capacité à lire et à écrire et selon leur achèvement du cycle primaire, %



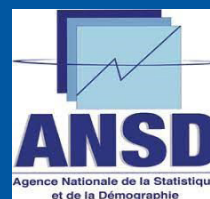
Source : Calcul des auteurs en utilisant le EHCVM 2018/19





Adresse UNICEF Sénégal

UNICEF Sénégal
Route des Almadies, Immeuble. Madjiguène
BP 29720, Dakar, Sénégal
Téléphone : (221) 33831-02-00
Fax : (221) 338820-89
E-mail : dakar@unicef.org



**Agence Nationale de la Statistique
et de la Démographie**

Rocade Fann Bel-air Cerf-volant, Dakar
116 Dakar RP -Sénégal
Téléphone : (221) 33 869 21 39
Fax : (221) 33 824 36 15
E-mail : statsenegal@ansd.sn